Lic. María Rosa Glasserman - Lic. Ana I. Martínez

Palabras clave:
Terapia Familiar Sistémica - Comunicación - Causalidad circular - Concepto de "verdad" - Trigeneracional - Escuelas de Terapia Familiar - Complejidad - Poder - Sistema terapéutico - Historia - Singularidad - Construccionismo social - Constructivismo - Diagnóstico relacional -Intervenciones -

1 HISTORIA DE LA TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA

La terapia familiar sistémica, como modelo clínico de abordar el sufrimiento individual, tiene sus orígenes alrededor de la década del 60, con la fundación del MRI, (Mental Research Institute), en Palo Alto, California. Desde principios del Siglo XX, cambios en distintas disciplinas, incluida la física, fueron creando las condiciones para este viraje en el modo de concebir al ser humano. La idea de la formación de este instituto, fue propuesta por Bateson, a raíz de su interés en el estudio de los procesos de comunicación. Los estudiosos de Bateson, dividen su obra en tres etapas: una primera más ligada a las ciencias naturales en la que se dedicó al estudio de la comunicación en los mamíferos superiores, una segunda a la que llaman "Antropológica", en la cual su interés se centró en los pueblos primitivos de la isla de Bali, por último distinguen una tercera, a la que denominan "Psiquiátrica", en la que su motivación era el estudio de los procesos de comunicación en los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Con este objetivo, convoca a Don Jackson, quién funda el Mental Research Institute. El proyecto se completa con la incorporación de Haley, Watzlawick y Weackland.(1)

Históricamente, los pacientes esquizofrénicos, por su complejidad, se han constituido en estímulo y desafío para la investigación, desde diferentes líneas teóricas; aun hoy, a

pesar de los avances a los que asistimos, provenientes de las neurociencias, la psiquiatría y la psicología, no hay una respuesta unívoca a este tipo de padecimiento.

El grupo de Palo Alto, estaba constituido en su mayoría por clínicos que muy rápidamente se van distanciando de la propuesta original de Bateson. Eran terapeutas y la clínica con pacientes graves los atrapa, la observación de los cambios en la conducta de dichos pacientes en presencia de algún familiar, se convierte en el foco de su atención, las conclusiones de esos estudios dan por resultado la publicación del texto "Teoría de la comunicación humana" cuya primera edición. data de 1971. Podemos pensar que la terapia familiar sistémica, en sus orígenes, se nutre de los aportes de por lo menos tres fuentes:

1) Los desarrollos de los teóricos de la comunicación, que nucleados en Palo Alto se dedican al estudio de los aspectos pragmáticos.

2) Los aportes de Ludwig Von Bertalanfy, quien formuló la Teoría General de los Sistemas.

3) Algunos conceptos que provienen de la Cibernética. Norman Wiener, es considerado el creador de la cibernética, disciplina que se ocupa de los procesos de control y regulación en el hombre, el animal y las máquinas. Muchos de los conceptos propuestos por Wiener, dieron lugar al desarrollo del campo de la robótica y la cibernética aplicada a la computación. A los terapeutas familiares les interesó y fue de gran utilidad en los comienzos del trabajo con familias, el concepto de retroalimentación, en sus dos valencias, positiva y negativa. Este concepto se convirtió, en el sustrato teórico de una de las herramientas conceptuales centrales del pensamiento sistémico: la causalidad circular.

Los teóricos de la comunicación de Palo Alto, informados de las postulaciones de Bertalanffy en su Teoría general de los sistemas, agregan al corpus teórico que servirá

de base a los terapeutas familiares sistémicos, su descripción de por lo menos dos niveles en la comunicación, uno verbal y otro para- verbal.

Como ocurre con frecuencia en los procesos de producción de conocimiento, fue algo no previsto, azaroso, lo que reorientó el foco de la observación, los comentarios de enfermeras y personal de la clínica, acerca de los dramáticos cambios en la conducta de los pacientes durante las visitas de sus familiares, desplazó el interés de los investigadores hacia los efectos de la interacción entre los miembros de la familia, poniendo de relieve los niveles no verbales de la comunicación, el contexto en que estos cambios se producían, y las redundancias conductuales. A partir de allí, es lo que pasa entre las personas y no en su interior, lo que se convierte en el objeto de estudio del grupo. La conducta de los pacientes es pensada como un mensaje que cobra sentido en su contexto familiar. La importancia que le otorgan al nivel no verbal de la comunicación es tal, que según postulan, califica al nivel verbal; no es solo lo se dice si no cómo se dice, el tono de voz, la actitud corporal, la gestualidad, lo que informa al receptor del contenido del mensaje.

Para el trabajo con familias, el grupo del MRI, parte de la aplicación de varios axiomas:

1) no es posible no comunicar.

2) toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional tales que el segundo clasifica al primero y es por lo tanto una metacomunicación.

3) la naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes.

4) toda comunicación implica dos niveles uno digital y otro analógico.

5) todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según se basen en la igualdad o la diferencia. (2)

Hasta ese momento, la comunicación se entendía como un proceso lineal. Dado un emisor (E) y un receptor (R) la información emitida por E llegaba a R siempre y cuando hubiera entre ambos un código compartido, que permitiera a R decodificar la información emitida por E. Si en el canal entre ambos no había ruido, la información llegaba correctamente al receptor.

A partir de la aplicación del concepto de sistema, para la comprensión de las relaciones interpersonales, cambia la concepción del proceso de comunicación. En una interacción entre dos individuos: A y B, pensados como sistemas abiertos, es decir que intercambian información con su medio (contexto), parte de la información que ingresa a B es procesada por éste y "sale" como respuesta que reingresa a A, produciendo a su vez en éste (A) una respuesta que re-ingresará a B, y así sucesivamente en tanto dure la interacción entre ambos. Según esta descripción el intercambio entre dos personas, se organiza con una causalidad circular.(2)

La Teoría General de los Sistemas, aporta varios conceptos al campo de la terapia familiar: sistema, reglas de relación, contexto, límites o fronteras del sistema, subsistemas, homeostasia familiar.(3)

Los teóricos de la comunicación, del grupo de Palo Alto, destacan los dos niveles de la comunicación: verbal y no verbal y jerarquizan las consecuencias del grado de congruencia o incongruencia entre ambos niveles, para la comprensión de la conducta sintomática.

La cibernética aporta el concepto de retroalimentación, positiva o negativa, según aumente o corrija la desviación.

Todos estos conceptos, constituyen las herramientas conceptuales que darán forma a múltiples teorizaciones en el desarrollo de la terapia familiar sistémica. Su evolución en el tiempo y su difusión en distintos centros de América y Europa, dio lugar a la creación

de varias líneas, que si bien comparten muchos de sus supuestos básicos, tienen entre sí, sensibles diferencias.

Si evaluamos la evolución de la terapia sistémica como un todo, podemos distinguir en este proceso, varias etapas.

Teniendo en cuenta cómo se conceptualiza el cambio y cómo se piensa el terapeuta en dicho proceso, es factible diferenciar un primer momento, más "holístico", impregnado del entusiasmo sistémico inicial: "El todo es más que la suma de sus partes". Los terapeutas de esa época (década del 60 al 70), tenían una mirada centrada en la totalidad, las reglas de relación, la homeostasis familiar; entendían el síntoma como emergente de la lucha entre la necesidad de cambio y los mecanismos de neutralización del cambio que la familia pone en marcha. Leyendo los textos de ese período, se advierte el uso de un léxico "de guerra": tácticas, estrategias, maniobras, desplegadas por los terapeutas, que pensaban su relación con la familia como un todo, desde una lógica directiva, implementando tareas que apuntaban a romper la "pauta de mantenimiento del síntoma", usando las mismas intervenciones para situaciones diversas.

Eran terapeutas que aun se pensaban objetivos en relación a su observación, que creían que las intervenciones debían ser fuertes, para desbloquear la dinámica familiar, que se había atascado en algún momento de pasaje del ciclo vital. El objetivo de la terapia era la resolución sintomática, ayudando a la familia a recuperar rápidamente la homeostasis. Desde este modo de pensar la "disfunción", se privilegiaban los procesos de retroalimentación negativa, que corrigen la desviación.

A principios de la década del 70, comienza una nueva etapa en el trabajo con familias Los resultados de las investigaciones de Prigogine (4) acerca del trabajo con sistemas alejados del equilibrio, son incorporados por los terapeutas familiares, que comienzan a

pensar que no siempre que un sistema se aleja del equilibrio, está condenado a su destrucción.

Mauricio Andolfi, de la escuela de Roma, fue uno de los pioneros en aplicar intervenciones que generaban un aumento de la tensión, del desequilibrio, intervenciones que se conocieron como de "inducción de crisis", "intervenciones provocativas", que al aumentar la tensión al interior de la familia, buscaban promover un cambio cualitativo en la red de relaciones familiares. (5)

A esta etapa que enfatiza los procesos de retroalimentación positiva, se la conoce como "segunda cibernética", para diferenciarla de la etapa anterior, que entendía el cambio a partir de estimular la corrección de la desviación (retroalimentación negativa), y se llamó "primera cibernética".

Ambas etapas se incluyen en lo que se llamó "Cibernética de primer orden". Esta designación alude a la relación S (terapeuta) O (familia). (6)

Si bien los aportes de la T.G.S., la teoría de la comunicación y la cibernética, ya formaban parte del bagaje teórico de los terapeutas familiares, aun no podemos hablar de un cambio epistemológico, todavía se trabajaba desde una supuesta objetividad, en la cual se hablaba de sistemas observados, con un terapeuta que se supone neutral, objetivo y "por fuera" del sistema.

El grupo de Palo Alto en California, J.Haley y Cloé Madanes en Washington, creadores de la línea estratégica; Salvador Minuchin y su modelo estructural; Mara Selvini Palazzoli y su grupo en Milán y Maurizio Andolfi en Roma son los encargados de consolidar y difundir los resultados de este nuevo modo de encarar el sufrimiento individual. El trabajo con familias queda instalado en el escenario de la psicoterapia: se

profundizan algunos desarrollos y aparecen variantes según la impronta de algunos de los pioneros.

De modo paulatino, seguramente estimulados por las situaciones de fracaso del método, la reflexión crítica y la investigación, llevada a cabo en algunas de las escuelas (la de Milán se destaca en este campo), surge la necesidad de rescatar la singularidad del individuo en la familia, que se había "diluido" en los primeros tiempos sistémicos.

El lenguaje de los textos va cambiando, ya no se habla solo en términos de totalidades y se producen nuevas conceptualizaciones. Se habla ahora del sistema terapéutico, no ya de la familia y el terapeuta.

Simultáneamente, las teorizaciones en otros campos del saber, impactan y sacuden otro de los pilares del trabajo terapéutico. El concepto de "objetividad" puesto en cuestión desde disciplinas como la física ya a principios del siglo XX, llega en los aportes de Maturana, Varela y Von Foerster a modificar el modo de pensarse de los terapeutas familiares en su relación con las familias, sus pacientes. La relación sujeto-objeto es de mutua implicación, no se puede hablar ya de sistemas observados, se trata de sistemas observantes. Llega así un segundo momento en la evolución de la terapia familiar.

Este sí puede considerarse un cambio epistemológico que hace caer algunos de los supuestos de la modernidad: la"Verdad" objetiva y aséptica, atemporal, y con ella la posibilidad de formular leyes universales, a históricas.

Cuando la subjetividad del terapeuta "filtra" y "tiñe" el producto de su observación, se trata entonces de "verdades" temporarias, hipotéticas y locales que le permitan entrar en contacto con la"realidad" de cada paciente, de cada familia, en un tiempo dado, en un lugar determinado y respetando su singularidad. (7) (8) (9)

2 El Movimiento de la Terapia Familiar Argentina

La terapia familiar en nuestro país se vio profundamente influida por todo el movimiento de salud mental que alrededor de la década del cincuenta comenzaba a evitar el aislamiento del enfermo, intentando darle cierta comprensión dentro del grupo familiar.

Los pioneros de este pensamiento fueron Enrique Pichon Rivière y Jorge García Badaracco, también José y Lily Bleger presentaron un trabajo en el Congreso de terapia Familiar de 1956. (40)

En este mismo año se crea en el Policlínico Araoz Alfaro el Servicio de Psicopatología en un Hospital General. Este movimiento lo lidera Mauricio Goldenberg e implica un puntapié inicial para romper el aislamiento del enfermo mental. No solo implicó la liberación física, sino también alguna de tipo conceptual: la conexión con los familiares y el retiro de rótulos, encasillamientos. Lo que llevó de alguna manera a intervenir con los pacientes y sus familias.

Las líneas teórico-clínicas de ese momento (los 60) eran la psicoanalítica que traía Isidoro Berenstein y la sistémica de ese momento (MRI) liderada por Carlos Sluzki (que a su vez provenía del psicoanálisis)quien desarrollaba esto en el servicio de Goldenberg. Esta privilegiaba la comunicación, la interacción y el movimiento antipsiquiátrico de Laing y Cooper.

Los profesionales se iban alineando detrás de aquellos que priorizaban que la conducta estaba determinada por lo interno lo inconsciente, lo histórico y aquellos que priorizaban lo actual, lo relacional, la secuencia comunicativa. El objetivo de las intervenciones era el cambio. Se buscaba conocer la estructura inconsciente de la familia o el bloqueo de la secuencia comunicativa y modificarlos mediante

intervenciones directivas o paradojales. Estos fueron los extremos de un abanico de procedimientos que se desarrollaban en la terapia familiar.

Estos grupos son los que organizan el Primer Congreso Argentino de Psicopatología del Grupo Familiar, que se realizó en junio de 1970 y que fue muy importante. Asistieron 1500 profesionales. Asistieron profesionales de la talla de Jay Haley, Harry Goolishian, Carlos Sluzki e Isidoro Berenstein.

Muchas de las personas que presentaron trabajos, dieron conferencias, participaron de mesas de discusión, fueron los precursores de los distintos grupos que se organizaron posteriormente en instituciones públicas y más adelante, privadas.

La década del 70 se puede dividir en dos momentos, el primero hasta la dictadura militar y la segunda desde 1976 al 83.

La primera estuvo caracterizada por los Centros Comunitarios de Salud Mental, donde los profesionales se insertaron en la comunidad, incluso entrando en las casas de las familias. Se incluyeron las técnicas de "impacto múltiple" de Goolishian y se trabajó mucho en la comunidad.

Con la dictadura militar de 1976, todas esas experiencias se vieron violentamente interrumpidas con lo que muchos de los nuevos desarrollos continuaron su curso en grupos privados que estaban fuera del ámbito institucional. La terapia familiar, como pensamiento relacional, que jerarquizaba la libertad, la autonomía en relación pasó a "las catacumbas"-

En el Centro Comunitario Nro. 2 (San Telmo) el Dr. Adolfo Loketek coordinaba el equipo de Familias y una de nosotras[1], coordinaba el equipo de Niños. Luego de ser expulsados con los restantes 98 profesionales en 1976, comenzaron a reunirse para desarrollar el pensamiento sistémico-relacional con los aportes de Minuchin, Haley, Watzlawick, Bateson, Whitaker y aquellos otros autores que entendían al ser humano en

[1] María Rosa Glasserman

relación dentro de su contexto (Laing, Sartre, Levi Strauss y sus correspondientes corrientes teóricas). También visitaron centros importantes del exterior (Instituto Ackerman donde estaban D. Bloch, Olga Silverstein) el primer curso en castellano (1979) en la Universidad de Stanford que organizó el Dr. Sluzki con muchísimos profesionales interesantes del momento y el San Francisco General Hospital donde él trabajaba.

En 1976, luego de salir del Centro 2 los coordinadores de Familias y Niños (Glasserman y Loketek) comenzaron a reunirse de modo autogestivo con otros profesionales a estudiar y desarrollar la temática. En 1977 se incorpora la Lic. Estrella Joselevich por unos años, coordinando a su vez un tercer grupo. Recién en mayo de 1979 se abre el Centro de Familias y Parejas (CEFYP), primera institución privada dedicada a la terapia familiar predominantemente sistémico-relacional.

Un año antes se había creado la Sociedad de Terapia familiar por el esfuerzo del Dr. Alfredo Canevaro. Estos dos grupos fueron muy importantes en los finales de la década del setenta y comienzos del 80. La Revista de Terapia Familiar fue creada y dirigida por Canevaro y parte del estímulo del interés por el tema, así como también los Congresos.

La intención de la Sociedad era abarcar todas las corrientes, pero lamentablemente comenzó a escucharse hablar de los “sistémico” como un conjunto de técnicas que se presentaban como enfrentadas con las corrientes dinámicas derivadas del psicoanálisis.

Pasó mucho tiempo para que pudieran dejar de enfrentarse y en algunos modelos poder integrar algunos conceptos.

Los sistémicos de ese momento privilegiaban la terapia breve, el cambio inmediato, las técnicas directivas, la instrucción, predominantemente se centraban en el síntoma. Seguían al MRI (Mental Research Institute) de Palo Alto y sus representantes en la Argentina eran el Lic. Hugo Hirsch y la Lic. Celia Alzufán entre otros. También había y hay representación de Salvador Minuchin a través de Pedro y Cecile Herscovici. Ellos

fueron, con otros, los que crearon en 1984 la Asociación Sistémica de Bs. As. que agrupó no sólo a profesionales de la salud mental sino también a otros provenientes de otros campos como el jurídico, escolar, empresarial, etc. Se creó también la revista Sistemas Familiares (/primera Directora Cecile Herscovici) como órgano científico de difusión de trabajos.

A mediados de la década de los 80, predominaba la escuela norteamericana en los terapeutas sistémicos, que ponían el acento en la conducta, lo ahistórico, lo actual. Un grupo de profesionales viró hacia un pensamiento más centrado en lo histórico, lo trigeneracional, los mitos familiares, en el concepto de juego familiar, en el lugar del individuo en el sistema y en el lugar del terapeuta. Este cambio también influyó en las técnicas terapéuticas y condujo a facilitar la emergencia de la palabra y la búsqueda con los pacientes de historias alternativas.[2]

A partir de la inclusión de supuestos humanísticos, antropológicos y filosóficos, se comenzaron a invitar a terapeutas europeos como Mony Elkaim (marroquí que vive en Bélgica) Mara Selvini Palazzoli, Mauricio Andolfi. También se incluyeron los nuevos paradigmas con pensadores como Humberto Maturana, Edgar Morin, Ilya Prigogine.

Fue muy importante el impulso que dio el encuentro interdisciplinario de carácter internacional "Nuevos Paradigmas: Cultura y Subjetividad" que organizó Interfas, bajo la dirección de la Dra. Dora Fried Schitman en 1991.

Claramente estamos marcando solo los comienzos de este movimiento, ya que luego surgieron muchos centros de formación y desarrollo de la terapia sistémica.

También en el interior fueron surgiendo grupos de terapeutas sistémicos casi todos especialistas en terapia familiar que fueron estimulados por cursos realizados con profesores que iban de la capital o ellos asistían desde el interior. Formaron centros de

[2] Wanda Santis, Fidel Lebensohn, José Bebchuk, María Rosa Glasserman, Adela García y otros

asistencia y formación en diferentes provincias. El Dr. Jorge Fernández Moya en Mendoza, el Dr. Lino Guevara en Neuquén y el Dr. Fidel Lebensohn en Rosario.

Dentro de los temas que se desarrollaron en esa época (finales de los 80) ha sido importante la violencia familiar con Silvia Mesterman, Adolfo Loketek y Cristina Ravazzola, donde en distintos encuentros se discutieron aspectos preventivos y asistenciales. Otro tema desarrollado de modo prioritario por Cecile Herscovici, son los trastornos de la conducta alimentaria. El estudio de la drogadependencia fue desarrollado por la Lic. Barilari y el Dr. Gastón Mazieres.

La Lic. Glasserman desarrolló el tema del divorcio destructivo, diferenciándolo del divorcio del ciclo vital, realizando una investigación de carácter clínico en los tribunales de Familia, con Jueces, asesores de Menores y asistentes sociales.[3]

Reiteramos que solo se está poniendo el acento en los inicios del movimiento. Hoy ésto se ha desarrollado con múltiples centros de terapia familiar con desarrollos propios.

Tomando en cuenta las escuelas mencionadas antes podemos resaltar que en la actualidad (2006) se hace hincapié fundamentalmente en las lineas que priorizan el diálogo, la jerarquización de la palabra.

Es interesante resaltar que a pesar de desarrollos importantes realizados en el tema de familias graves, aún no hay respuestas precisas. Eso sí, cabe destacar la importancia de la creación de un dispositivo clínico compuesto por el terapeuta individual, el psiquiatra y el terapeuta familiar.

Tendremos que seguir adelante con nuestras investigaciones clínicas para poder paliar el sufrimiento humano que significan las psicosis y otras enfermedades equivalentes.

[3] DR Cárdenas, Dr. Molina. Lic. Silvia Crescini y más adelante Ana Martínez.

2 DIFERENTES ESCUELAS DE TERAPIA FAMILIAR

Desde sus orígenes hasta el presente la terapia familiar se ha desarrollado en distintos lugares, Europa, EEUU, Latinoamérica, Australia. Muchos de los centros en los cuales se practicó como abordaje clínico, fueron también institutos de formación, hecho éste que favoreció su expansión como recurso para paliar el sufrimiento; distintas promociones de terapeutas al egresar de sus centros de formación fueron a su vez creando otros institutos de formación y asistencia.

El MRI en Palo Alto, California, fundado por Don Jackson en la década del sesenta, fue como ya lo señalamos, el primer centro de investigación y asistencia en el trabajo con familias desde una óptica sistémica. Luego en otras ciudades de EEUU se crearon otras instituciones que, incluyendo los aportes de los clínicos de Palo Alto, se dedicaron al trabajo con familias y parejas. Cada uno de estos centros fue haciendo sus propios desarrollos, modificando y enriqueciendo los aportes del comienzo.

En la década del setenta, se consolidan diversas escuelas que si bien comparten los supuestos de base de lo que conoce como paradigma sistémico, tienen entre sí, marcadas diferencias.

En EEUU las líneas Estructural (Minuchin) y Estratégica (Haley-Madanes) en Europa las de Roma (Andolfi) y Milán (Selvini Palazzoli y su grupo), incorporaron los conceptos de los teóricos de la comunicación, pero les imprimieron cada una su sello. Posteriormente, en Francia, Bélgica, Alemania e Inglaterra, diferentes grupos comenzaron a trabajar con familias estimulados por los aportes de los pioneros. En Italia, dos miembros del equipo original del grupo de Milán, se separaron de M. Selvini Palazzoli: Gianfranco. Cecchin y Luigi Boscolo y fundaron su propio instituto. (10) (11)

3 ESCUELA ESTRUCTURAL

Salvador Minuchin, argentino radicado en EEUU, con amplia experiencia en el trabajo con niños de diferentes grupos sociales y etnias varias, describe lo que para él, sería un modelo funcional de familia. Cada familia, pensada como ”matriz de identidad”, se organiza en su decurso, para el cumplimiento de ciertas funciones que se esperan de ella: socializar a sus miembros, favorecer su crecimiento individual, estimulando su autonomía sin perder su sentimiento de pertenencia. Para que este proceso sea posible, la familia se organiza en diferentes subsistemas: parental, conyugal, fraterno, cada uno de los cuales tiene funciones o tareas específicas. Para Minuchin los límites (o fronteras) entre los subsistemas, deben ser claros y firmes pero flexibles, para permitir los cambios que el curso del ciclo vital demanda. Entiende por límite al conjunto de reglas que definen quién pertenece y de qué modo y quién no pertenece a determinado subsistema. Los diferentes subsistemas pueden formarse por función, afinidades, género o generación. El subsistema conyugal, constituido por ambos miembros de la pareja, debería permitir la mutua acomodación de los adultos y potenciar los aspectos creativos de cada uno, estimulando el proceso de crecimiento individual, ofreciendo el sostén emocional a sus miembros que les permita tolerar las tensiones provenientes del mundo externo, como así también las vicisitudes de la crianza de los hijos en el curso del ciclo vital. La pareja pensada en la relación con sus hijos, encarna el subsistema parental. Minuchin considera al subsistema parental como el subsistema rector, ejecutivo, es decir aquel que establece las normas y el cuidado de los hijos, su orientación y protección. En aquellas familias donde uno de los hijos participa de estas funciones, mostrando una coalición (*) con uno de sus padres, que deja fuera al otro padre, hay riesgo de problemas ya que están alteradas las jerarquías. Esto revelaría una posible disfunción en el subsistema conyugal (uno de los miembros de la pareja se apoya más en un hijo que en el otro de la relación) y además perturba el desarrollo de ese hijo al incluirlo en actividades que exceden sus posibilidades evolutivas. El subsistema fraterno

es considerado como el “primer laboratorio social”, allí los niños aprenden a negociar, cooperar, competir. La posibilidad de participar en la creación de alianzas cambiantes entre iguales, la experiencia de situaciones de solidaridad o el manejo de la rivalidad, es un entrenamiento útil para la vida, que a veces no han tenido aquellos que no tuvieron hermanos. La claridad en los límites y las jerarquías son dos de los conceptos centrales de su enfoque. (12)

Según el estilo relacional de cada familia, Minuchin las clasifica en dos grupos: familias aglutinadas y familias desligadas. Cada uno de estos estilos no es en sí mismo disfuncional, todo depende de cómo se adecuan a él los distintos miembros de cada familia. Ambos tipos de familias tienen ventajas y desventajas para sus miembros. En las diferentes etapas del ciclo vital, los distintos subsistemas pueden ser más desligados o más aglutinados.(**) (12)

(*) Distinguimos los conceptos de alianza y coalición, alianza significa la unión de dos en relación a alguna afinidad o actividad compartida, coalición es la unión de dos en contra de un tercero.

(**) Las familias desligadas se caracterizan por tener más firmes las fronteras entre subsistemas y más laxas las fronteras con el afuera. Las familias aglutinadas por el contrario tienen las fronteras entre subsistemas más permeables y más rígidas las fronteras con el afuera, son las familias a las que les cuesta incorporar nuevos miembros (los cónyuges por ejemplo), pero de las que también se hace más difícil desprenderse. (12) (13) (14)

Caso clínico

Consulta por un hijo adolescente sintomático

La familia está formada por Cecilia de 49 años, Esteban de 48 y Ezequiel de 16 años

Ambos padres son profesionales destacados en su especialidad, priorizan la actividad intelectual y comparten un alto nivel de autoexigencia en su rendimiento laboral.

Consultan derivados por el pediatra de Ezequiel, a quién consultan siempre que tienen alguna duda o preocupación por su hijo.

El motivo que desencadena la derivación es que los padres se enteran, un año antes, que Ezequiel fuma marihuana. En esa oportunidad Cecilia y Esteban se reunieron con los padres de los compañeros de Ezequiel, todos hablaron con sus hijos, hicieron reuniones conjuntas de los adultos con los adolescentes, los chicos prometieron "que no lo iban a hacer más", los padres de todos se tranquilizaron y un año después, se enteran que en un campamento al que todos concurrieron, organizado en el campo de un amigo, todos habían llevado y consumido marihuana.

Ezequiel que estaba cursando su 4º año en un colegio prestigioso y exigente, había disminuido su rendimiento escolar, tenía varias materias en riesgo y mostraba una conducta desafiante frente a las autoridades y profesores. Cuestionaba permanentemente las normas institucionales y criticaba a sus padres por haberlo inscripto en ese colegio.

Ambos padres estuvieron de acuerdo con la consulta, en la primera entrevista Cecilia parecía más convencida que su marido, él se definió como alguien "reticente a las terapias". Ezequiel se mostró bien dispuesto, con ganas de hablar con "alguien que escuche, con ellos no se puede, no entienden nada y no escuchan"

En el consultorio se ubican Cecilia y Ezequiel en dos sillones y Esteban en una silla auxiliar, a la derecha de Cecilia.

Cecilia comienza su relato enfatizando su dolor por la mentira y por haber perdido la confianza en Ezequiel. Para ella el tema de la marihuana es central; para Esteban en cambio la principal preocupación es el bajo rendimiento escolar que considera "inadmisible"; para Ezequiel el problema son los padres, sus constantes discusiones que le "llenan la cabeza", según él cuando fuma es para no escuchar las peleas y los gritos,

se va a casa de unos amigos, allí todos fuman y se evade. Si se queda en la casa interviene intentando mediar entre los padres, generalmente apoyando al padre, ya que su madre es “una exagerada, todo lo magnifica y se desborda, gritando por cualquier cosa”. Ahora lo enoja que su papá esté tan insistente con el tema del colegio, discuten, él se desborda y golpea alguna cosa o rompe algo.

Cuando “pelean” dice Esteban, yo no le hablo por dos o tres días (refiriéndose a Ezequiel) cuando esto ocurre, Cecilia se siente mal porque le parece desmedida la reacción de Esteban y ella trata de interceder “haciéndole comprender a Ezequiel el carácter del papá”. Cuando la “pelea” es con la madre, Esteban no interviene aunque a veces Ezequiel la insulta y “se gritan de igual a igual”.

Desde una mirada de corte estructural, podríamos describir en este breve relato algunas características de la dinámica familiar, ligadas a las conductas disfuncionales de Ezequiel.

1-Desacuerdos en el subsistema parental en relación a temas que involucran a Ezequiel: La madre prioriza en su preocupación el consumo de marihuana, el padre el rendimiento escolar.

2-Desacuerdos y malestar en el subsistema conyugal, que tiene una frontera lábil que permite la inclusión del hijo en los problemas de la pareja.

3-Jerarquías poco claras entre el subsistema parental y el filial, por momentos tanto en la sesión, como en los relatos de ellos de la vida cotidiana, parecen todos iguales, simétricos, sin una diferenciación entre los adultos y el adolescente.

4-Ligado al punto anterior, alianzas cambiantes entre cada uno de los padres y el hijo, a veces con la forma de una coalición, que deja afuera al otro padre y al hijo en una situación confusa en relación a su lugar en la relación. Por momentos es un aliado, por momentos alguien que debe obedecer a alguno de los adultos, reconociendo su autoridad.

5-Otro dato importante que apreció más tarde en las entrevistas es lo que Minuchin describía como alteraciones inter generacionales en las jerarquías. Los abuelos maternos de Ezequiel lo apoyan constantemente, le regalan objetos y dinero, muchas veces desconociendo indicaciones de los padres.

Una posible intervención "reestructurante" en este caso sería estimular un acercamiento de los padres entre sí que les permita trabajar en equipo, logrando un fortalecimiento de sus capacidades que les permita frenar las intromisiones de los abuelos en la crianza.

Más adelante describiremos más en detalle los distintos tipos de intervenciones.

En este caso en particular, desde el encuadre, se propuso una etapa de entrevistas con los padres solos sin el hijo (dos entrevistas seguidas, una por semana solo con los padres y la tercera con los tres), para trabajar estas cuestiones.

En las entrevistas realizadas con los padres sin Ezequiel, fueron surgiendo temas relativos al subsistema conyugal; la posibilidad de discutir sus desacuerdos y el malestar instalado en la relación sin la presencia del hijo, les ofreció un modelo de resolución de sus conflictos que no involucrara a Ezequiel. En las entrevistas con los tres, se focalizó en ayudar a Ezequiel a salir de ese lugar entre sus padres, a pesar de perder el privilegio que éste le ofrecía. Él se presentaba como mediador y víctima de las discusiones y desacuerdos, pero ese lugar le daba mucho poder, coligándose con uno u otro de manera cambiante, cuestionando la autoridad de los adultos en el momento de la puesta de límites.

3 ESCUELA ESTRATÉGICA

Jay, Haley y Cloé Madanes fundan en Washington D.C. lo que se conoce como la escuela Estratégica, a partir de los desarrollos de Milton Erickson. Trabajan con muchos casos de jóvenes que están en la etapa de desprendimiento de su familia de

origen. Piensan, que la tarea central del terapeuta es planear estrategias que resuelvan los problemas del cliente. No aplican las mismas estrategias a todos los casos, plantean una específica para cada uno. Se proponen ayudar a los consultantes a sobrellevar las dificultades que les plantean las diferentes etapas del ciclo vital. Su abordaje se centra en el presente, toman en cuenta el contexto social en el que el individuo está inmerso, y además de intervenciones directivas usan la indicación de tareas a algún miembro de la familia o a varios de ellos. Definen "problema" como un tipo de conducta que forma parte de una secuencia de actos entre varias personas, desde esta mirada piensan que uno de los objetivos del terapeuta es interrumpir la repetición de la secuencia que sostiene la conducta disfuncional. Para lograrlo una de las intervenciones clásicas consiste en cómo redefinir el problema presentado de un modo tal que sea posible su resolución. Del mismo modo que Minuchin, suponen que la familia no es una organización entre iguales y por lo tanto prestan atención a cómo se distribuye el poder y la congruencia o incongruencia de la jerarquías.

Este enfoque presta mucha atención a la trama social más amplia en la que se incluye la persona que consulta, los profesionales que intervienen del ámbito de la salud, el ámbito educativo o jurídico. Las intervenciones que realizan pueden incluir a veces a estos profesionales, no solamente a los miembros de la familia.

Las intervenciones pueden ser directas o paradojales; en ocasiones son sencillas y otras veces muy complejas, la idea es motivar a la familia a ponerse en movimiento, para lograr su objetivo, las directivas deben ser precisas, planeadas y en algunos casos se ensayan en sesión. Es una psicoterapia centrada en el presente, que parte de aceptar la función directiva del terapeuta, no buscan estimular la comprensión del por qué del problema, si no su resolución; no está orientada al crecimiento personal, tratan de ayudar a la familia a organizarse de un modo más funcional, para lo cual fijan reglas,

trabajan sobre las fronteras generacionales y se plantean objetivos limitados. Es un abordaje ligado al concepto de terapia breve. (10) (15) (16) (17)

3 ESCUELA DE ROMA

Maurizio Andolfi es para muchos terapeutas familiares sistémicos el "representante" del grupo de Roma, hay sin embargo, un grupo de reconocidos profesionales que trabajaron con él en distintos momentos de su evolución: Carmine Saccu, Paolo Menghi, Anna Nicolò entre otros. Andolfi reconoce en su trabajo la poderosa influencia de algunos de sus maestros, Salvador Minuchin y Jay Haley, como así también de Kitty Laperriere del instituto Ackerman.

Cuando Andolfi comienza a trabajar sistemáticamente con familias, la terapia familiar sistémica en su conjunto, ya tenía varios años de desarrollo. El entusiasmo "holístico" de los primeros tiempos, estaba dando paso a un reconocimiento de la necesidad de no perder la singularidad del individuo en pos de la insistencia en focalizar en los procesos de totalidad. Los aportes desde el campo de la química de Ilya Prigogine, acerca de cómo pensar los sistemas alejados del equilibrio, brindaron a los terapeutas familiares herramientas conceptuales para pensar los procesos de cambio desde una óptica diferente. En la primera etapa de la terapia familiar la idea rectora era ayudar a la familia a recuperar rápidamente la "homeostasis", eliminando la conducta sintomática. Este criterio estaba ligado al concepto de terapia breve, focalizada, con objetivos limitados, en la cual la intervención del terapeuta era puntual, precisa y apuntaba a la ruptura de la pauta de mantenimiento del síntoma. Una vez cumplido este objetivo (la resolución sintomática), se dejaba a la familia en la confianza de sus recursos para la salud. La intervención terapéutica tenía por objeto ayudar a recuperar rápidamente el equilibrio ya que si el sistema se alejaba demasiado esto era pensado como peligroso.

La incorporación por parte de los clínicos de los desarrollos de Prigogine, especialmente los conceptos de “punto de bifurcación” y “estructura disipativa” (4) permitió pensar los procesos de cambio, en los sistemas alejados del equilibrio. Las intervenciones de los terapeutas mostraron este cambio. Andolfi fue uno de los que difundió lo que se conoce como intervenciones de inducción de crisis. En las familias con miembros graves caracterizadas por la rigidez de sus reglas de relación, Andolfi proponía un tipo de intervención conocida como “provocación”, tendiente a desestabilizar el sistema. En uno de sus textos hizo una distinción en dos tipos de familia: 1) Familias en riesgo, aquellas en las cuales en distintas etapas, diferentes miembros de la familia portan un síntoma.

2) Familias con designación rígida, aquellas en las cuales, el paciente designado es siempre el mismo y se trata generalmente de situaciones graves. (5)

En el enfoque de la escuela de Roma, el terapeuta es un miembro activo del sistema terapéutico, que se hace responsable de su lugar de poder. Desde esta óptica el sufrimiento está ligado a las dificultades en el proceso de individuación. En toda familia, pensada como un sistema, se pueden distinguir dos tendencias, a la continuidad (garantía del sentimiento de pertenencia) y a la transformación, indispensable para acomodarse al crecimiento de los individuos en el transcurso del ciclo vital. Cuando las necesidades individuales de uno de sus miembros, son vividas como amenaza a la homeostasis familiar, se ponen en movimiento procesos de neutralización del cambio; como “producto” de esta lucha emerge la conducta sintomática. Según Andolfi, el paciente sintomático es “la puerta de entrada al sistema”, ya que resume en sí las dos tendencias con la misma intensidad: la tendencia al cambio y al no cambio, de allí su parálisis. Por esta razón la intervención del terapeuta debe provocar la función que está cumpliendo el paciente con su síntoma, en esa familia, en ese momento. Si bien el enunciado de la intervención se dirige al paciente designado, la provocación está

dirigida a todo el sistema.(5) Andolfi y su grupo incluyeron la variable trigeneracional en el trabajo con familias, distinguiendo los conceptos de mito individual y mito familiar, sus mutuas relaciones y el trabajo en sesión con rituales que apunten a visualizar "el sistema mitológico de la familia y permitir su evolución" (18)

Los aspectos centrales de este enfoque los podemos resumir como: evaluar el grado de rigidez o flexibilidad de las reglas de relación; ayudar a la diferenciación de los miembros de la familia favoreciendo los procesos de individuación; aumentar la tensión mediante intervenciones provocativas que tienden a generar un cambio cualitativo en las relaciones familiares, "descargando" al paciente designado cuya centralidad proviene de concentrar en sí la "disfunción" familiar. Cuanto más grave es el síntoma de uno, más "sanos" pueden ser los demás. Desplazar al paciente de su lugar, por un lado lo alivia, pero también le resta centralidad y poder por lo tanto el terapeuta debe ser fuerte y rápido para resultar eficaz en su intento de tomar el control de la sesión.

Este enfoque asigna un papel destacado a la función del terapeuta en el nuevo sistema: el sistema terapéutico. Supone que el terapeuta, al entrar en contacto con la familia, pasará a formar parte de una trama relacional en la cual tendrá un lugar de privilegio para estimular el cambio. Para lograr su propósito, tendrá que identificar qué función la familia pretende asignarle, empaparse de las imágenes y metáforas con las cuales los miembros de la familia describen su padecer, proponerles una "verdad nueva" y evaluar la intensidad de la intervención, para que ésta no resulte destructiva. (5) (19)

Caso clínico I

Consulta una familia formada por Eduardo de 50 años, Estela de 48, Silvina de 19 y Javier de 14.

Los deriva el terapeuta individual de Javier. Hace 2 años que está en tratamiento por consumo de marihuana. Las conductas transgresoras de Javier, en la casa (robó 300

dólares) y en el colegio (están a punto de expulsarlo por su falta de respeto a docentes y autoridades, además de su bajo rendimiento escolar) promovieron en el terapeuta individual la necesidad de una derivación a un espacio de terapia familiar.

Contexto familiar en el momento de la consulta

Eduardo y Estela, separados desde ocho meses antes, no mantienen una buena relación, lo cual les dificulta la posibilidad de llegar a acuerdos en relación a cuestiones relativas a los hijos.

La separación se produce por una infidelidad de Eduardo; Javier buscando plata en los bolsillos de un traje de su padre, encuentra la carta de una mujer, se la da a su hermana que se la entrega a la madre quien entonces "descubre" la infidelidad de su marido y lo echa de la casa.

Además de los mutuos reclamos por la mentira, la traición, el abandono y el desamor, Estela y Eduardo, en el momento de la consulta, tenían serias discusiones por temas económicos en relación a la cuota de alimentos que Eduardo se había comprometido a pagar y no cumplía.

A las entrevistas concurren todos. Javier se sienta entre su madre y su hermana, Eduardo se ubica más distante, dejando una silla libre entre él y su hija, se sienta al lado de la puerta. Este detalle es importante ya que la distribución espacial de los pacientes en el consultorio es un dato que "muestra" al terapeuta algunos aspectos de la dinámica familiar. En este caso:

1-Paciente designado (Javier) ocupando un lugar central

2-Paciente designado entre la madre y la hermana

3-Padre más distante, lejos del grupo de tres que conforman la madre y los hijos.

4-Hija mayor parentalizada

Cuando comienza la entrevista toma la palabra la madre, cuyo relato pormenorizado de las difíciles conductas de Javier es apoyado desde lo gestual por el padre, que asiente con la cabeza y por Silvina que aporta comentarios. Javier se ríe nervioso, se mueve mucho y con un movimiento hacia adelante y atrás con la silla toca ocasionalmente un adaptador que está detrás, dónde está conectada la lámpara que ilumina el consultorio, por lo tanto repetidas veces la luz se enciende y se apaga por segundos. Ningún miembro de la familia le dice nada.

Frente a las preguntas del terapeuta, Estela narra otras cuestiones del contexto familiar de los últimos meses, todas situaciones dolorosas que crean un clima de tristeza en la sesión, cuando esto ocurre, Javier hace algún chiste que cambia rápidamente la emotividad del momento, generando risas en los miembros de su familia.

Silvina cuenta sus dificultades para sostener una relación estable de pareja, tuvo varios novios que según ella "no le duran"; Estela habló de su dolor por tener que internar a su madre en un geriátrico ya que padece demencia senil, a ella por sus obligaciones laborales le resulta imposible cuidarla personalmente; Eduardo contó que poco tiempo atrás murió un bebé hijo de su hermana, cada vez que alguien de la familia se emocionaba contando estas cosas, sistemáticamente, Javier intervenía con algún comentario risueño que los "sacaba" de la tristeza.

Los relatos de Silvina y de Estela que incluían a Eduardo, estaban plagados de descalificaciones, situación que se podría describir como de una coalición madre-hija, que excluye y cuestiona al padre. Frente a esta situación, la respuesta de Eduardo es el silencio y el aislamiento creciente.

Sobre el final de la sesión el terapeuta hace una intervención que, pensamos es un buen ejemplo de lo que Andolfi llamó *intervención provocativa.*

Dirigiéndose a Javier le dice: "¿cuánto fue que robaste vos? ¿300 dólares? Me parece que es poco che, con todo el trabajo que vos estás haciendo por tu familia y te van a

arreglar con 300 dólares… vos logras hacer reír a tu mamá a pesar de lo triste que está por haber tenido que internar a tu abuela, distraes a tu hermanita para que no se ponga a pensar qué le pasa que no "le duran" los novios, con todos los líos que haces en el colegio y en tu casa lograste traer a tu papá y hacerle sentir que es importante a pesar de las críticas de estas dos mujeres… yo creo que vas a tener que robar más viejo, es poca plata 300 dólares por todo eso… o pedirles que te paguen…eso sí, vos te vas a arruinar tu vida, entre la marihuana y los robos… no sé cómo vas a terminar, pero a ellos los ayudas mucho."

Todos los elementos que el terapeuta toma para construir su intervención, fueron expresados por los pacientes durante la sesión, solo que ahora están articulados de otro modo. La intervención si bien se le expresa al paciente designado (el paciente según Andolfi es la puerta de entrada al sistema) va dirigida a todo el sistema, cada uno de ellos escucha algo que lo toca en lo personal, pero el énfasis está puesto en la función del paciente, reforzando su lugar central, del cual no le es fácil moverse: llama la atención, distrae, convoca. Se trata de una intervención paradojal, el terapeuta "indica" al paciente aquello por lo cual consultan (robo), intenta desestabilizar al sistema provocando un aumento de la tensión en el sistema como un todo; la última parte de la intervención "vos te vas a arruinar tu vida" rescata al individuo en su singularidad, señalando los riesgos de la conducta transgresora.

Caso clínico II

Ejemplo del trabajo de Andolfi

Haremos referencia a una experiencia clínica realizada en 1984, en una institución de terapia familiar[4] en la que recibimos la visita del Dr. Mauricio Andolfi.

[4] CEFYP- Centro de Familias y Parejas

La terapeuta a cargo del caso era una de nosotras[5] . La familia llega a la consulta a través de una consulta de la madre, quien pide ayuda porque su hijo Javier está detenido por haber asaltado un negocio de ropa. Es probable que quede en libertad, ya que es el primer incidente legal desde que cumplió 18 años. Le darán libertad vigilada. Su padre vive en otra provincia. Los padres están separados hace muchos años. La madre vive con sus dos hijos Javier y Carolina de 16 años.

La primera consulta se realiza en enero de 1984. El padre acuerda en asistir a la primera y última consulta de evaluación familiar.

En aquel momento nuestro trabajo teórico familiar era distinto que ahora (2007)

La terapeuta define la conducta de Javier como "llamado al padre", observando la complicidad habitual en las familias de adictos. Posterior a la separación, el padre pone como condición para el pago de los alimentos, la asistencia regular al colegio. Javier no asistía a clase con la anuencia de su madre. Naturalmente ella no le informó al padre porque carecían de medios para comer y ésta era la condición para seguir recibiendo el dinero.

La intervención final de esa entrevista fue redefinir la conducta de Javier como la de un Robin Hood Moderno (sacrificial) que roba a los ricos para ayudar a los pobres. También se les manifiesta la función ("justiciera") de Javier como brazo ejecutor de la madre

Durante un pequeño lapso, conseguimos que el padre se quede en Bs. As. y se logró incrementar la terapia con su presencia. Hasta ese momento no estaban claros la adicción y el nivel de consumo. Ciertas intervenciones provocativas a la función de Javier dieron su fruto. En una sesión más tarde, Javier pudo contar, con un gran monto de angustia, que fuma marihuana, aspira cocaína y trafica, pidiéndole al padre ayuda.

[5] Lic. María Rosa Glasserman

Es en este período que recibimos la visita del profesor Andolfi. El se incorpora a una entrevista que definiremos como de consulta centrándose en la redefinición del síntoma de Javier. Me pregunta, (ya que al no vivir aquí no sabe), cómo se llama algún elemento que pegue fuertemente dos objetos. Le digo "poxipol" A continuación, él le dice a Javier: "Desde cuando se te ocurrió ser el poxipol de esta familia?" Es decir hace referencia a lo que él siente como función del síntoma: unir lo que está separado.

La intención no es ahondar en el caso, sino poder incluir de fuente directa lo que llamamos más arriba "intervenciones provocativas"

3 Instituto de Bruselas

Mony Elkaïm, neuropsiquiatra, dirige el Instituto de estudios de la familia y de sistemas humanos de Bruselas.

El modelo de trabajo creado por Elkaïm, significó un importante aporte al campo de la terapia familiar.

Articulando los desarrollos de I. Prigogine, H. von Foerster, H. Maturana y F. Varela, formuló conceptos que resultaron de gran utilidad para el trabajo clínico con parejas y familias.

Su interés se centró en cómo pensar las consultas e intervenir en sistemas abiertos, es decir en proceso de cambio, respetando la singularidad de cada familia, sus reglas intrínsecas, teniendo en cuenta el azar y la historia. Cuando habla de sistema abierto se refiere al sistema terapéutico, es decir que incluye al terapeuta como parte de esa trama relacional que va desarrollándose en el espacio-tiempo terapéutico. Aborda el tema de la emergencia del observador y formula dos conceptos que permiten al terapeuta "usarse" con sus pensamientos, sentimientos e historia, en el trabajo con los pacientes: *resonancia y ensamblaje*.

Define ensamblaje como "el conjunto creado por diferentes elementos en interrelación en una situación particular, elementos que pueden ser tanto genéticos o biológicos como ligados a reglas familiares o a aspectos culturales o sociales. Un ensamblaje terapéutico puede estar constituido por elementos a los cuales se aplican leyes generales, por elementos ligados a reglas intrínsecas de ese sistema terapéutico particular o por singularidades." (41)

La resonancia "no es más que un caso particular de ensamblaje constituido por la intersección de diferentes sistemas alrededor de un mismo elemento; las resonancias son elementos redundantes que ligan los universos más dispares, mientras que las singularidades, aunque autorreferenciadas, permanecen únicas."

Algunos párrafos de uno de sus textos "*Si me amas, no me ames*", darán cuenta más claramente, de su modo de pensar la clínica con familias.

En relación al tema del lugar del terapeuta, dice: "…se vuelve imposible de describir una situación terapéutica cualquiera sin aceptar que se está incluido en ella; lo que sucede en esa situación es siempre circular, y construyo lo que digo de una familia mientras ella misma me construye, en el mismo proceso" y más adelante agrega "Una psicoterapia lograda no significa que el terapeuta tenga razón, sino que la construcción que edificó con los miembros del sistema terapéutico es operatoria."

Tomando el concepto de acoplamiento estructural de Maturana y Varela (43), dice: "en el marco de la psicoterapia, no es la verdad o la realidad lo que importa, sino la construcción mutua de lo real. Acoplamientos diferentes hacen emerger mundos diferentes y sin embargo compatibles."(41).

Los conceptos de resonancia y ensamblaje, por su complejidad, le permiten trabajar en la clínica desde distintos niveles: la pareja o familia, el terapeuta, el supervisor, la institución de la que forman parte. "Los sentimientos que nacen en uno u otro miembro del sistema terapéutico no remiten únicamente a la historia de esa persona; se trata con

seguridad de una vivencia singular, pero amplificada y mantenida por un contexto, de tal suerte que lo que vive uno de los protagonistas del sistema terapéutico está a la vez ligado a él y no es reducible a él."

El texto citado más arriba, cuya primera edición es de 1989, muestra claramente un momento de la evolución de la terapia familiar sistémica, en su pasaje de lo que se llamó "primera cibernética" (trabajo con sistemas cercanos al equilibrio) a la "segunda cibernética" (trabajo con sistemas alejados del equilibrio), como así también las semillas de lo que luego se conocería como cibernética de segundo orden (la emergencia del observador como parte de lo observado).

Los desarrollos del constructivismo y el construccionismo social, fueron los referentes teóricos de ésta última etapa, aun en crecimiento.

En el libro de Kenneth Gergen, publicado en castellano en 2006 *"Construir la realidad",* (42) con prefacio de Mony Elkaïm, hay un jugoso diálogo entre ambos que da cuenta de este proceso aun en marcha en el campo de la terapia familiar sistémica, en sus diversas líneas.

3 ESCUELA DE MILÁN

Durante la década del 60, con el estímulo de la promulgación en Italia de la ley de desmanicomialización (Basaglia), muchos terapeutas comenzaron a buscar recursos para ayudar en el proceso de re inserción de los pacientes crónicos, largamente hospitalizados en sus familias.

Mara Selvini Palazzoli tomó contacto con los desarrollos de Gregory Bateson, y los trabajos de los clínicos de Palo Alto, en 1968, se reúne con otros colegas: Giuliana Prata, Gianfranco Cecchin y Luigi Boscolo, con la intención de aplicar las nuevas ideas en el tratamiento de pacientes graves. Se los conoció por medio de sus publicaciones

como los Asociados de Milán, trabajaron durante muchos años con un método que los distinguió de otros grupos y se dedicaron prioritariamente a la investigación. Comenzaron su trabajo con familias con niños con graves desórdenes emocionales para luego extender la aplicación de su método a otras situaciones de consulta. Trabajaban dos parejas mixtas, una en el consultorio con la familia y otra detrás del espejo unidireccional. (10)

Este grupo se caracteriza por el rigor en sus investigaciones, la producción escrita en la que dan cuenta de sus resultados y la autocrítica. En cada nueva publicación hacen un resumen de lo realizado hasta el momento y explican las razones del porqué de los cambios, sus fracasos, sus dudas y sus nuevas ideas.

Con una clara impronta estratégica (MRI), en la primera etapa del trabajo del equipo (1971-1975), usaban intervenciones tendientes a garantizar el control, por parte del terapeuta, de la relación terapéutica. Su estilo era directivo y prescriptivo y la intervención paradojal, en todas sus variantes, la intervención privilegiada. Como su objetivo principal era la investigación, su interés se centró en el estudio minucioso de los "errores" y los fracasos a mediano y largo plazo de procesos que al comienzo habían sido exitosos.

Lo primero que encontraron fue que no podían aplicarse a todas las situaciones, las mismas intervenciones. La connotación positiva o la redefinición del síntoma como un "sacrificio" del hijo para juntar a los padres, se reemplazó por intervenciones paradojales específicas para cada caso, diferenciando la relación entre la conducta del hijo sintomático y el efecto en cada uno de los padres. (10)

En una segunda etapa, que abarca el decenio 1975 - 1985 se consolida lo que se conoció como el "Modelo sistémico de Milán". La atenta lectura de los textos de Gregory Bateson provocó un giro en el modo de pensar las relaciones familiares, la consulta y el lugar del terapeuta en el nuevo sistema: el sistema terapéutico.

En un artículo llamado “Hipótesis, circularidad, neutralidad”, los Asociados de Milán enuncian tres principios para la conducción de la sesión que se convirtieron en el sello de su abordaje clínico.

4 Hipótesis sistémica

Consideraban fundamental la elaboración de una hipótesis, que les permitiera entrar en contacto con la familia. No se trataba de “descubrir” la “verdad “ de lo que ocurría, si no de organizar los datos vinculados al síntoma, de manera tal que éste tuviera sentido en el marco de las relaciones familiares. Para lograr este objetivo, la hipótesis debía ser circular y relacional. Una vez planteada a la familia, no se buscaba comprobar su veracidad, alcanzaba con que fuera viable y estaba siempre sujeta a revisión.

4 Circularidad

El interrogatorio circular consistía en hacer preguntas que tendían a introducir diferencia y estimular la reflexión; por ejemplo pedirle a un miembro de la familia que explique como él ve la relación entre otras dos personas de su familia (preguntarle a un hijo acerca de algún aspecto de la relación entre sus padres, o a una esposa cómo ella describiría la relación de su marido con su propio padre).

4 Neutralidad

La posición de neutralidad, describe la conducta del terapeuta que en su actitud se conecta con todos los miembros de la familia sin hacer alianza con ninguno en particular, sin emitir juicios morales.

Para el primer grupo de Milán el “objeto” de su investigación clínica era muy preciso: los trastornos mentales más graves en niños y adolescentes.

Como producto de una creciente insatisfacción con los métodos estratégicos, se fueron alejando lentamente del modelo sistémico de los pioneros y buscaron otras herramientas conceptuales. (20)

En la década del 80, comienzan aplicar en el estudio de los procesos psicóticos, la "metáfora del juego".

Para ellos la idea de pensar en los "juegos familiares", les brindaba un lenguaje apto para integrar las reglas generales que describen y regulan las relaciones interpersonales (razonamiento sistémico) con las conductas individuales (razonamiento estratégico).

Las palabras que se asocian a la idea de juego: grupo, equipo, posiciones individuales, estrategias, tácticas, alternancia de "movidas", les permitían abordar la comprensión simultanea de los dos niveles: el sistémico (la familia) y el individual (cada uno de sus miembros).

Desde esta nueva óptica se proponen subsanar el reduccionismo sistémico, cuyo énfasis en la mirada holística de los procesos borraba la singularidad del individuo.

Otra ventaja del uso de la metáfora del juego, para la comprensión de las relaciones familiares, es que permite un enfoque que contemple las múltiples conexiones entre las movidas y contra movidas (nivel individual) vinculadas a las movidas de los otros de la relación (nivel micro sistémico), articuladas con las reglas socioculturales (nivel macro sistémico), todas influidas por hechos azarosos, imprevisibles.

Con el uso de la metáfora del juego pudieron superar la ceguera holística en lo referido a las diferencias de poder y grados de libertad, propios de una organización que evoluciona en el tiempo como es la familia.

Estas diferencias las definen en varios niveles:

1) Jerárquico (no es un grupo de iguales)
2) Cultural
3) Subcultural (clase social, zona urbana, zona rural)

4) Relacional (lugar en el juego intrafamiliar)

5) Individual (talentos y características personales)

Pensar la dinámica familiar en términos de juego, permite además recuperar la variable temporal; las interacciones individuales se organizan en secuencias en el curso del ciclo vital. Reinstalaron así, reivindicándola, la dimensión histórica, descartada por los abordajes sistémicos centrados en el presente.

Como producto de sus investigaciones aportaron un modelo para la comprensión de la emergencia de los procesos psicóticos en la familia. Según ellos pueden describirse seis estadíos en el proceso interactivo que da origen a la psicosis, es un proceso que requiere de muchos años para producir un paciente señalado, la circularidad está en la historia, no en el aquí y ahora.

Los seis estadios son:

El impasse en la pareja conyugal

La intromisión del hijo en el juego de la pareja

La conducta inusitada del hijo

El viraje del presunto aliado

La eclosión de la psicosis

Las estrategias basadas en el síntoma (21) (20) (10)

3 Caso Clínico

Nos referiremos a un caso donde se puede ilustrar el tema de los juegos psicóticos.

Susana consulta por su hijo Juan de 11 años. Viene sola la primera vez ya que viven en Trenque Lauquen. Ella vive con su marido y dos hijos más pequeños. La derivación a terapia familiar la realiza el neurólogo que consultan y que decide que lentamente le irá

quitando toda la medicación que otros neurólogos y psiquiatras le han ido dando a modo de prueba, sin mucho efecto.

En esa entrevista, la madre cuenta que su hijo tiene un diagnóstico de (Toc) trastorno obsesivo compulsivo y de hiperkinesia. Ella está sufriendo una situación de pareja muy angustiante y quiere divorciarse pero no se anima ya que su marido dice que si ella lo concreta, él la va a matar, luego a los chicos y por último se va a suicidar.

Susana sabe que él tiene una amante desde hace muchos años. Esta es una entrevista donde se puede ver el despliegue de lo que el mismo grupo ve como los juegos psicóticos.

Como ya señalara en otra oportunidad (34) la comprensión de la conducta del niño por el que se consulta es totalmente diferente si la vemos en el contexto familiar. En ese marco, muchas de las situaciones sintomáticas se vuelven inteligibles.

En la entrevista familiar se despliegan escenas cuyo sentido está dado por la interacción. Hoy sé que para producir algún cambio, dentro de lo posible, tendremos que transitar un tramo de modo conjunto con la familia, para colaborar en la transformación de las dinámicas relacionales.

Ha habido un cambio de paradigma en el procesamiento de la información clínica y en la consulta por los niños. Se ha incorporado una concepción relacional del desarrollo humano. Se ha pasado del estudio del niño a la observación de él con sus significativos. Es decir: del sujeto a la relación. (35)

Tomemos a Juan, y si nos sumergimos en la subjetividad de la madre que no pudo amamantarlo, veremos que ella no pudo verificar la respuesta de sentirse apta para responder a su ser deseante. Al respecto, Dío Bleichmar dice que “un recién nacido llorando es la imagen de la indefensión”. En el primer período, en general, hasta los dos meses, el desafío para las madres se focaliza en su capacidad para atender y regular el

cuerpo del bebé con sus funciones básicas. Ahí comienzan a aparecer y desarrollarse las modalidades de contacto acompañadas de la intensidad emocional. Estas se inscribirán en el infante como representaciones interactivas de "estar con", creando expectativas de repetición más y más específicas, mientras dan lugar a la aparición del sistema de apego del bebé. Esto está naturalmente ligado al sentimiento de seguridad de la madre que debe estar tranquila, ya que sus propias necesidades de apego se verán activadas, necesitando ella, a su vez, de figuras continentes que la acompañen y la contengan. Como veremos más adelante, Susana no contaba con su familia, que vivía lejos y, además, tenía conflictos con su marido y con la familia extensa de él.

No sabemos en el caso de Juan, cuánto de genético o biológico hay en su disfunción, pero estamos seguros que la relación es tanto parte de la génesis como del mantenimiento de su trastorno. El déficit temprano generalmente está ligado a un desencuentro interpersonal como una desregulación entre las necesidades del infante y los sistemas motivacionales del adulto" (35). Este es el caso de las madres primerizas, quienes suelen cambiar radicalmente su identidad ante la aparición de un nuevo ser desconocido que ingresa en la vida de la pareja, con los cambios que esto implica. Si esto es difícil, cuánto más lo es, con los bebés que duermen pocas horas, que están alertas y los hipertónicos que suelen reaccionar en extremo a los estímulos en forma estridente.

El bebe y su madre se van interregulando de modo afectivo, especialmente si el niño encuentra en la relación un rápido alivio, que a su vez activa el apego que intensifica el bienestar de *estar con.* El caos se instala si frente a dificultades en la díada no aparece una reparación interactiva. La madre entonces se empieza a sentir impotente, inútil, al no ser capaz de calmar a su bebé. Este es el caso de Juan y su madre, quien a su vez era criticada por su marido y su familia extensa de Trenque Lauquen, sin contar con el apoyo de la suya propia.

En la primera entrevista conjunta se escenifica con gran claridad el sufrimiento que ocasionó, por sus características, el nacimiento de Juan a la vida de esta pareja, y se extendió a otros miembros de las familias extensas.

Las hipótesis propuestas por Mara Selvini Palazzoli y colaboradores (21) sustentan la aparición del fenómeno psicótico en un proceso que transcurre en seis estadios, comenzando con el *impasse* de la pareja conyugal. Aunque no son de carácter absoluto, en mi experiencia lo he visto desarrollarse en algunos casos de este tipo de familias. Este es uno de ellos, con la salvedad que no lo describiré como "la verdad", sino como un punto de vista alternativo que complementa tanto las teorías del desarrollo infantil, como lo descripto anteriormente en la relación diádica madre-hijo. En esas descripciones falta el padre y las familias extensas.

La historia de esta pareja ha transitado múltiples vicisitudes que nos permiten decir que en el momento de la consulta, ellos se encontraban en lo que Selvini Palazzoli llama "el impasse de la pareja"(primer estadio). El inicio de este juego es arbitrario. Se puede puntuar en cualquier momento, pero tomando en cuenta esa vieja frase de Framo (1965) que se refiere a que siempre que hay un hijo sintomático hay una pareja conyugal con dificultades y que en cambio no toda pareja con problemas engendra hijos sintomáticos.

Como "impasse de la pareja" ella describe a "jugadores" enfrentados a situaciones sin salida, no hay crisis, ni escenas catárticas, ni separaciones liberadoras. Son provocaciones acompañadas de jugadas estratégicas. Ejemplo de eso en la entrevista es cuando **O.** hace referencia a la satisfacción que le produce cuando su hijo ataca a la esposa "aunque luego sabe que se le volverá en contra" o cuando mandaba a dormir a la casa de sus padres a Juan para desagradar a **S.** Es decir, situaciones en que el hijo deja de ser sujeto y pasa a ser objeto que, a su vez, se convierte en arma de ataque.

El error epistemológico del futuro paciente designado consiste en considerar que uno de los progenitores es una víctima del otro y entonces él comienza a intervenir activamente en defensa de la supuesta víctima. En la sesión mencionada es muy claro que las intervenciones de Juan se dirigen a proteger y defender al padre, atacando a la madre con insultos. También se puede observar en un momento en que el padre llora, él le dice a la madre: "Por tu culpa!".

Este es el segundo estadio: *la intromisión del hijo en el juego de la pareja*. También podemos referirnos a este aspecto como coalición transgeneracional, situación repetida en las familias con pacientes gravemente perturbados.

En el tercer estadio aparece *la conducta inusitada del hijo* donde se va desarrollando en él cada vez más agresión dirigida al progenitor supuestamente vencedor.

En el cuarto estadio hay un *viraje del presunto aliado*. Es decir, que a pesar de sus "defensas", el progenitor defendido, ya perturbado por la conducta insólita de su hijo,(sintomática) se preocupa y de alguna manera se une al otro miembro de la pareja parental en la preocupación y muchas veces esto lleva a realizar la consulta.

Esto es muy claro en la secuencia de esta sesión comentada en el momento en que los padres acuerdan en cuanto a la historia familiar y a los errores cometidos. Aparece ahí el reconocimiento de la madre en relación de situaciones difíciles de ella con Juan, el sufrimiento que esto le trae, su deseo de ser mejor madre y esposa. Esto produce emoción en el padre y en cierto modo se produce una pequeña unión entre ellos, que "enloquece" a Juan ya que en principio él malinterpreta esta situación. (Se siente"traicionado" por su padre)

El quinto estadio *es la eclosión de la psicosis*, que en el caso de Juan se refiere al empeoramiento de los síntomas en muchas áreas. Esto se ve claramente en la sesión cuando percibe el acercamiento entre sus padres.

El sexto estadio se refiere a *las estrategias basadas en los síntomas* cuyo efecto pragmático consiste en mantener dichos síntomas. Suelen aparecer obstáculos para la continuidad del tratamiento. Esto es sintéticamente lo que ocurre en el desarrollo del proceso

En esta entrevista tenemos todos estos elementos intrasesión. Hay muchísimas situaciones para observar: el dolor de los padres, la coalición de Juan con su padre en contra de la madre y el particular dolor de **S**. y su ambivalencia, percibida por Juan como abandono, el reproche. El padre conmovido al escuchar el dolor y arrepentimiento de la madre.

Obviamente que estas situaciones difícilmente se dan de manera pura y tampoco pensamos que se aplica a todos los casos. Usamos este caso para ejemplificar el tema de los juegos psicóticos.

3. CENTRO DE TERAPIA FAMILIAR DE MILÁN

Muchas de las conclusiones obtenidas por el Grupo de Milán en la investigación fueron más tarde aplicadas a la comprensión de los trastornos de la conducta alimentaria.

Posteriormente, Gianfranco Cecchin y Luigi Boscolo, se separan del grupo original y fundan el Centro Milanes de Terapia Familiar. Una de las diferencias de este centro en relación al anterior es que ellos si se dedican a la formación de terapeutas. El estímulo del trabajo con los alumnos, los llevó a replantearse su trabajo con las familias y desarrollaron también un modelo de trabajo con pacientes individuales desde una óptica sistémica.

Se nutrieron de los aportes de H. Goolishian y Harlene Anderson, difundiendo en Italia los desarrollos del Construccionismo Social. (24)

Después de varias décadas de desarrollo, la terapia familiar se renueva en las décadas del ochenta y del noventa, con los aportes de otras disciplinas.

Ilya Prigogine, Edgar Morin, Von Glasersfeld como antes hicieron Von Foerster y Maturana, enriquecen desde campos ajenos a la psicología, el bagaje conceptual de los terapeutas familiares. (4) (7) (8) (9) (11) (22) (37) (38)

En ese período se ponen en cuestión desde diferentes vertientes algunas de las nociones características de la modernidad.

Los modos de pensar la "realidad", la producción de conocimiento y el papel del lenguaje en este proceso, transforman la relación del sujeto con su entorno y su manera de pensarse en esta relación.

Desde principios del siglo XX, las fronteras entre ciencias duras y ciencias blandas, se modifican, desde la física y la química, la neurofisiología, la filosofía, la lingüística, la psicología, la sociología y la antropología, surgen corrientes de pensamiento que se articulan en sus desarrollos en lo que podríamos definir como un nuevo paradigma.

Dos de estas corrientes, tuvieron un fuerte impacto en la evolución teórica de la terapia familiar sistémica y su aplicación clínica: el constructivismo y el construccionismo social. Hasta entonces se pensaba que el lenguaje era representacional, y que la función central de la comunicación era la transmisión de mensajes, por lo tanto se la pensaba como un proceso secundario.

El constructivismo y el construccionismo social, si bien abrevan en tradiciones filosóficas diferentes, coinciden en cuestionar esta idea acerca del lenguaje y la comunicación. Para ambas corrientes el lenguaje construye el mundo, es decir que es formativo. Consideran como la función clave del lenguaje la construcción de mundos humanos y entonces la comunicación se convierte en un proceso constructivo y no en la mera transmisión de mensajes, desde esta óptica se considera a la comunicación como el proceso social primario. (23)

El constructivismo se centra en el lenguaje. Ernst von Glasersfeld resume los puntos salientes del constructivismo "es un modo de pensar y no una descripción del mundo, es

un modelo. No hace afirmaciones ontológicas... no nos dice cómo es el mundo, sólo nos sugiere una manera de pensarlo... es el primer intento de separar la epistemología de la ontología..." El constructivismo excluye la idea tradicional acerca de que el cono cimiento debe ser la representación del mundo externo, propone en su lugar la idea de que el conocimiento debe ser viable, debe cumplir una función y adecuarse así a nuestros objetivos. El constructivismo centra su interés en el observador y sus construcciones mentales que emergen del "encaje" del organismo y su medio. (23)

El construccionismo social focaliza en las actividades como medio constructivo. Se centra en el producir y el hacer. "El mundo social consiste en conversaciones, definiéndolas como diseños de actividades conjuntas semejantes a juegos" (Barnett Pearce). Los seres humanos tienen, según Pearce, la capacidad de incluirse en varios juegos a la vez, que se rigen por ciertas reglas de obligatoriedad (lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer). Cada individuo participa de distintos juegos (es simultáneamente el padre de sus hijos, el hijo de sus padres, el empleado de su jefe, el amigo de su amigo) cada uno de sus actos es co-construido en la interacción social. Esto quiere decir que el significado de sus acciones cobra sentido en la secuencia interpersonal en la que se produce. Para comprender lo que ocurre en cierto momento, la unidad mínima de análisis debería incluir tres acciones (acción-respuesta-respuesta a la respuesta). El construccionismo social piensa la comunicación como un proceso circular Las personas van construyendo su identidad de acuerdo a los lugares que van teniendo en ese entramado de múltiples juegos superpuestos. (23) (26) (27)

La aplicación de estos supuestos a la práctica clínica, transformó fuertemente el trabajo con familias.

El objetivo de la terapia, el lugar del terapeuta como miembro del sistema terapéutico, el trabajo de sesión, todo esto se modificó en relación al trabajo de las primeras etapas de la terapia familiar. La psicoterapia no se piensa ya como "resolución de problemas"

(Haley), sino como un lugar donde en el hablar se disuelven los problemas. El terapeuta con esta orientación se considera un estimulador del diálogo, cuya participación facilita la re narración de la historia del paciente mediante la emergencia de nuevos significados. El trabajo terapéutico consiste en encontrar nuevas formas para dialogar sobre aquellos puntos de la historia que al paciente le preocupan o le acarrean sufrimiento, tratando de crear otros sentidos que permitan entender y explicar las experiencias vividas. El supuesto es que en esta transformación no solo aparecen relatos diferentes, es el sí mismo de cada narrador el que se modifica. (23)

El construccionismo social pone el acento en las relaciones, no ya entendidas como pautas de interacción, sino como sistemas de lenguaje y significado.

La terapia sistémica de corte estratégico, priorizó la observación del nivel sincrónico, era un abordaje terapéutico centrado en el presente.

Luigi Boscolo y Gianfranco Cecchin, mostraron la relevancia del trabajo con el tiempo en las relaciones humanas, desplazando el interés hacia el modo en que las personas cuentan y se cuentan su historia. Los seres humanos tienden a organizar los episodios de su vida, en una secuencia temporal que le de sentido a su presente articulando los hechos pasados y las expectativas futuras. La consideración del aspecto temporal amplió el foco de su atención a un nivel diacrónico, buscando comprender cómo los pacientes construyen sus historias conectando pasado, presente y futuro. El sufrimiento apareció así ligado a historias deterministas que los encierran, limitando su crecimiento y el desarrollo de sus potencialidades. (31)

El interés por la narrativa, vinculó a estos terapeutas italianos al grupo constituido por Michael White y David Epston en Australia, como así también a Carlos Sluzki, Harlene Anderson y Lynn Hoffman en E.E.U.U. y Tom Andersen en Noruega. (10)

3. Terapia sistémica individual

Muchas veces en los grupos de formación, surge la pregunta acerca de la posibilidad del trabajo con pacientes individuales, desde una óptica sistémica, ya que el término "sistémica" ha estado ligado tradicionalmente al trabajo con familias y parejas.

Nos parece importante transmitir que el abordaje sistémico no se trata de un conjunto de técnicas que permitan intervenciones más o menos espectaculares, directivas o no para promover el cambio, se trata de una epistemología, es decir, un modo singular de pensar al individuo, la construcción de su subjetividad y la emergencia del sufrimiento que lo conduce a la consulta. Si el terapeuta tiene incorporada esta epistemología, puede aplicar esa lente al trabajo con pacientes individuales. A partir de la década del 80, algunos terapeutas familiares comenzaron a incomodarse con los aspectos "reduccionistas" de la teoría tal como había sido formulada en los primeros tiempos: una mirada holística, que jerarquizaba los procesos de totalidad, atenta a la relevancia del contexto, centrada en las interacciones y apoyada en el concepto de "caja negra" que dejaba afuera todo lo no visible, perdiendo de vista la "interioridad" del individuo y concentrándose exclusivamente en sus intercambios conductuales con los otros. Los aportes del constructivismo y el construccionismo social con su énfasis en el lenguaje y la hermenéutica, permitieron conectar al individuo con sus otros de un modo que elimina la dicotomía "afuera-adentro" (11) Si a esto le agregamos el modo de pensar la relación terapéutica como un proceso de construcción conjunta de significados, pensamos que en la medida en que el terapeuta participe de esta epistemología, podrá aplicarla en la clínica también al trabajo con pacientes individuales.

Algunos autores se han ocupado de pensar un modelo de trabajo especialmente pensado para el abordaje clínico individual. Luigi Boscoso y Paolo Bertrando del Centro de Terapia de la Familia de Milán, publicaron en 1996 (primera Ed. en castellano año

2000) un texto dedicado a este tema. (11) A partir de 1990 comenzaron una investigación acerca del trabajo con pacientes individuales. Describen distintas situaciones a partir de las cuales podían sugerir un abordaje individual.

a) Un adulto casado cuyo cónyuge se niega a hacer una consulta conjunta.

b) Un adulto separado o divorciado con dificultades para aceptar el proceso de separación y que pide una consulta de pareja o de familia.

c) Adolescentes o adultos jóvenes que después de una experiencia de terapia de familia quieren un espacio para pensar temas relativos a su vida y su futuro.

d) Adolescentes o adultos jóvenes que siempre se negaron a participar de una experiencia de terapia conjunta con la familia.

e) Individuos que aunque cuenten con otros miembros de su familia, estén en proceso de desprendimiento de la familia y se beneficien por lo tanto de un espacio individual.

En todos estos casos la duración del tratamiento es variable entre una y veinte sesiones.(11) El tema del tiempo ha sido especialmente tenido en cuenta por estos autores, no solo en lo relativo a la duración del tratamiento, si no respecto del concepto con el que se manejan los terapeutas según su marco teórico y sobre todo han llamado la atención acerca de la importancia del "ajuste" entre el tiempo del consultante y el tiempo del terapeuta en el momento de evaluar el proceso y los ritmos del trabajo terapéutico. En su abordaje se interesan tanto por el pasado como por el presente y el futuro, buscando contrastar la articulación lineal de la historia con la que el consultante llega a la consulta.

Llaman a su modelo *"terapia breve-larga",* breve porque en general el número total de entrevistas no supera las veinte sesiones y larga porque el intervalo entre las mismas es de dos a cuatro semanas entre sesión y sesión, lo cual da como resultado final una duración aproximada de un año y medio.

Para la conducción de la sesión utilizaron al comienzo los principios que fueron formulados por el grupo de Milán para el trabajo con familias:

1- Formulación de hipótesis
2- Circularidad
3- Neutralidad (ver antes en este mismo artículo página 32) PONER LLAMADA

Recientemente en su visita a Buenos Aires, Paolo Bertrando nos actualizó acerca de algunas modificaciones realizadas al modelo de trabajo en entrevistas individuales.

3 TERAPIAS NARRATIVAS

En la última década del Siglo XX, la terapia familiar sistémica, consolidó un giro que venía anunciándose desde algunos años antes. Muchos terapeutas familiares cuestionaron las metáforas características de la teoría de sistemas y de la cibernética; en la clínica se pasó del énfasis en los comportamientos al interés en los relatos que traen los pacientes a la consulta.

Así como en los primeros tiempos de la terapia familiar sistémica, los clínicos se nutrieron de conceptos provenientes de la física, la cibernética, la biología y la química, después de varias décadas de desarrollo, los terapeutas familiares incursionaron en otros campos del saber: la filosofía, la crítica literaria, la teoría social y en algunos casos, los desarrollos de la crítica feminista.

Michael White en Australia y David Epston en Nueva Zelanda, coincidieron en sus intereses y lograron, a partir de un fructífero intercambio, aportar al campo de la terapia familiar nuevos recursos para el trabajo clínico.

Dos temas centrales recorren la obra de estos autores y le dan una impronta singular a su trabajo:

1- La “externalización del problema”

2- El múltiple uso de la palabra escrita como medio terapéutico.

1- Externalización del problema

M. White al hablar de “externalización del problema” lo que intenta explorar es la relación existente en la interacción entre las personas y los problemas; la pregunta que se hace es : ¿está consiguiendo la persona influir sobre el problema o es el problema el que más influye en la persona? (39)

Los seres humanos están en el lenguaje y como tales construyen su identidad a partir de su “saber” de sí y de las descripciones que cada uno hace de sí; estas descripciones están enraizadas en prácticas lingüísticas basadas en construcciones sociales y patrones socioculturales invisibles que condicionan, moldean, limitan o potencian ciertas descripciones y no otras.

Las personas cuentan su vida y en este contar y contarse quiénes son, la estructuran y le dan sentido. Esta historia es casi siempre una narración parcial que no da cuenta de la complejidad de la experiencia vivida, pero acaba convirtiéndose en dominante y moldea la identidad del individuo, la persona “está narrada por la cultura”, “la persona se relata a sí misma la historia dominante que le relatan otros Partir de este supuesto implica su aceptación de la influencia en su pensamiento de algunos de los desarrollos de Foucault en relación al inextricable vínculo entre conocimiento y poder

“Objetivar el problema significa mostrarlo como un producto de procesos de institucionalización de tipo cultural, social e histórico” (10)

White y Epston no son terapeutas que dan soluciones, buscan despertar en el consultante el cuestionamiento de estas versiones dominantes generando un aumento del sentimiento de su poder personal; para ello utilizan distintos tipos de preguntas, con el objetivo de de- construir la versión limitante con que llega a la consulta y permitirle desplegar otras de sus potencialidades.

Preguntas de “conjunción”, preguntas “relativas al problema”, preguntas con “influencia relativa”, preguntas que revelen los “resultados únicos”[6] .

Las respuestas a este tipo de preguntas posibilitan la de- construcción del relato inicial, externalizando el problema y hacen posible pasar a la última etapa del trabajo que consiste en la “construcción de historias alternativas”. El foco inicial en el trabajo de White y Epston es el individuo para pasar luego a las relaciones.

La lectura de los textos de Bateson, introdujo a White en el “método interpretativo”, entendido como el estudio de los procesos mediante los cuales desciframos el mundo. El significado que se le atribuye a un determinado suceso está condicionado por el conjunto de supuestos y premisas que forman nuestros **mapas** del mundo, si la objetividad no es posible, conocer es interpretar.

Según White la obra de Bateson también lo conectó con la importancia de incluir la dimensión temporal al afirmar que toda información “es la noticia de una diferencia”, la percepción de la diferencia es lo que genera respuestas nuevas, situar los eventos en el tiempo es lo único que permite percibir la diferencia, es decir el cambio.

El concepto de narración le permitió sumar al concepto de mapa la dimensión temporal, ya que toda narración en su organización, incluye una secuencia, un orden que la hace más adecuada para el abordaje de procesos de cambio y desarrollo. (39)

Aplicando todos estos conceptos al trabajo con familias, se aleja de los primeros teóricos de la terapia familiar en su visión del sufrimiento que lleva a la consulta, él no piensa que una estructura disfuncional determina los comportamientos e interacciones familiares si no más bien que el significado que los miembros de la familia atribuyen a los hechos es lo que determina sus comportamientos. Por esta razón su interés se centra en cómo las personas organizan sus vidas en torno de ciertos significados y cómo al

[6] Para más detalles sobre este tipo de preguntas ver “Historia de la terapia familiar” Bertrando y Toffanetti, pg.319

hacerlo colaboran sin saberlo en la persistencia del problema. Cambia la óptica del enfoque ya que en vez de pensar que el sistema "necesita" del problema, propone pensar que son las exigencias del problema lo que constriñe a las personas en su sostenimiento.

La externalización del problema es un recurso que utiliza para tratar de ayudar a los miembros de la familia a distanciarse de las descripciones "saturadas por el problema". (39)

2-El múltiple uso de la palabra escrita como medio terapéutico

Epston destaca especialmente el potencial terapéutico del uso de la palabra escrita como recurso en el trabajo clínico.

Cartas, invitaciones, certificados, cartas de referencia, declaraciones, son usados con fines terapéuticos. Al terminar cada sesión Epston hacía una carta resumen que entregaba a la familia y una copia quedaba como copia en la historia clínica. "El contenido es seleccionado cuidadosamente para generar distinciones que puedan resultar heurísticas, para conectar determinadas experiencias y acontecimientos que prometen crear recursos, y para promover aquellos "relatos" con potencial curativo." Utilizando un lenguaje vulgar, con palabras habituales pero usadas de forma novedosa trata de estimular la imaginación y la participación del lector en el texto.

Ambos, tanto Epston como White utilizan la analogía del texto para pensar el trabajo en terapia, a la que proponen pensar como un proceso de contar y volver a contar las vidas y experiencias de las personas que acuden con problemas.

El pensamiento narrativo se basa en prácticas lingüísticas que tienen en cuenta la subjetividad de la experiencia y su complejidad, sitúa a la persona como protagonista de su mundo, mundo que se construye y reconstruye en el contar y recontar su historia frente y con sus semejantes que serán copartícipes de esta "re- escritura" que moldea sus vidas y sus relaciones.(39)

En el texto que venimos citando, los autores resumen los aspectos centrales de su práctica mencionando algunas de sus más salientes características:

1-Enfatiza la importancia de las vivencias de la persona

2-Colocando las experiencias vividas en la dimensión temporal, favorece la percepción cambiante del mundo.

3-Invoca el modo subjuntivo al desencadenar presuposiciones, establecer significados implícitos y generar perspectivas múltiples.

4-Estimula la polisemia y el uso del lenguaje coloquial y poético en el intento de construir nuevos relatos.

5-Invita a adoptar una postura reflexiva.

6-Fomenta el sentido de la autoría y re autoría de la propia vida y de las relaciones de cada persona al contar y volver a contar la propia historia (39)

2 EL LUGAR DEL TERAPEUTA Y LA MODIFICACIÓN EN SUS INTERVENCIONES EN LA EVOLUTIVA DE LA TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA.

Cuando para describir las características de algún modelo clínico, hacemos una distinción entre los aspectos teóricos y prácticos, sabemos que se trata de una división artificialmente construida, con fines didácticos. Teoría y práctica están indisolublemente unidas en la experiencia clínica. Revisar los distintos modos de intervenir el terapeuta, en las diferentes líneas de terapia familiar sistémica, nos permitirá por lo tanto dar cuenta del cambio epistemológico que se produjo al interior del movimiento de la terapia familiar en el curso de su desarrollo, evolución y consolidación en estas décadas. Para abordarlo proponemos una síntesis comparativa de los puntos de coincidencia y divergencia entre algunas de las líneas más difundidas.

3 MODELOS ESTRATÉGICOS

Con la muerte de Don Jackson en 1968, el MRI cambió varias veces de director. En 1974 P. Watzlawick, J. Weakland, A. Bodin y R. Fisch, publicaron un artículo central en relación al trabajo con familias, que dio lugar a la posterior publicación de varios libros del grupo, el método de terapia breve del MRI se difundió a partir de entonces como "el modelo de Palo Alto".

En 1973 J. Haley publicó su texto "Terapia no convencional" y más tarde en 1976 "Terapia para resolver problemas" en el cual se va delineando su propio modelo, que si bien siguió siendo claramente estratégico, se diferenció del de Palo Alto por su énfasis en los aspectos jerárquicos y normativos. Teniendo en cuenta cómo piensan el síntoma, la función del terapeuta y por lo tanto las intervenciones, algunos autores establecieron diferencias entre ambos modelos estratégicos; describieron al de Palo Alto como más centrado en el "proceso" y al de Haley / Madanes más centrado en la " forma".

Ambos modelos coinciden en:

1) Los problemas que llevan a la consulta son relacionales y no individuales
2) La función del terapeuta es identificar el problema y estimular su resolución
3) Lo que importa para la terapia es el comportamiento observable
4) El terapeuta debe ser activo y sus intervenciones directas en relación a los comportamientos
5) El que define el problema es el cliente no el terapeuta
6) Se usan intervenciones directas y paradojales: connotación positiva, redefinición, tareas en sesión y fuera de sesión
7) Como el problema lo define el cliente, parte del trabajo es establecer un contrato entre cliente y terapeuta acerca de los cambios esperados

Ambos modelos difieren en

1) Su modo de pensar el síntoma

Para el grupo del MRI los problemas que llevan a la consulta resultan de aplicar soluciones equivocadas a situaciones de la vida cotidiana o a la dificultad para encontrar nuevas respuestas a los desafíos que plantean las distintas etapas del ciclo vital. Por eso indagan especialmente las soluciones intentadas, sostienen que la función del terapeuta es "romper la pauta de mantenimiento" del síntoma.

Para Haley y Madanes, el síntoma expresa una incongruencia jerárquica (cómo se distribuye el poder) que revela muchas veces alianzas o coaliciones transgeneracionales. Es un modelo normativo ya que supone que existe una organización jerárquica adecuada, que no produce disfunción.

La función del terapeuta es por lo tanto reorganizar las estructuras desequilibradas, debe mostrarse firme y fuerte en su determinación de impedir al cliente el control en la definición de la relación terapéutica, para lo cual aplica estrategias y tácticas en sesión.

Además de intervenciones paradojales, como la prescripción del síntoma, Haley utiliza también la prescripción de rituales y ejercicios de negociación. En general dan tareas a realizarse fuera de sesión. En una primera fase de la terapia, tienden a establecer una relación de cooperación con los clientes, evitando confrontaciones. Las intervenciones están focalizadas en la conducta disfuncional y su lugar en la secuencia que la sostiene.

Las líneas estratégicas comparten algunos puntos con el enfoque estructural:

Se centran en el presente, tienden a ser terapias breves, el concepto de ciclo vital es importante para el diagnóstico, los comportamientos individuales cobran sentido en el contexto más amplio, familiar y social, por lo tanto si cambia el contexto, cambia el comportamiento individual, las intervenciones terapéuticas intentan modificar las secuencias repetitivas disfuncionales. (15) (16) (17)

3 ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL MODELO ESTRUCTURAL QUE DIFIEREN DE LOS ABORDAJES ESTRATÉGICOS:

Las intervenciones del terapeuta están dirigidas a la estructura familiar de la que suponen emerge la conducta sintomática.

El terapeuta es directo, enérgico y no evita la confrontación. En una misma sesión establece alianzas cambiantes con distintos miembros de la familia. Estimula a los pacientes a realizar en sesión conductas diferentes. Las tareas para el hogar buscan consolidar los cambios hechos en sesión, son generalmente intervenciones directas: redefiniciones, desafío a pautas de interacción observadas en sesión y muy pocas veces se utilizan intervenciones paradojales.

El terapeuta estructural se propone cambiar la estructura familiar y para este objetivo interviene desde la primera sesión perturbando las pautas de interacción que considera disfuncionales. Se "usa" a sí mismo como agente de cambio, graduando la distancia en un continuo que va de la máxima cercanía a la posición más distante. Como muchas de sus intervenciones están basadas en el desafío, necesita generar una fuerte alianza al comienzo para poder luego perturbar las secuencias habituales que muestra la familia.

El desafío como intervención es una técnica compleja que requiere del terapeuta experiencia y capacidad de empatía, como así también firmeza para conducir la sesión. En su implementación se pueden describir tres etapas: escenificación, focalización e intensificación.

1) La escenificación consiste en pedir a la familia, después de un período de observación de interacción espontánea, que reproduzca una secuencia determinada en la que el terapeuta intentará producir alguna modificación. La respuesta de los miembros de la familia a los cambios que introduzca el

terapeuta, le permitirán medir el grado de flexibilidad o rigidez en las pautas de interacción.

2) La focalización se refiere a la selección por parte del terapeuta de un tema para trabajar cuya importancia no fue enfatizada por la familia en su exposición del problema. Si el terapeuta logra que todos se interesen en él, esto habla de un buen encuentro entre el terapeuta y los pacientes, que aceptan el punto jerarquizado por el terapeuta.
3) La intensificación consiste en el énfasis necesario en la intervención que aporta novedad en sistemas familiares más rígidos, que rápidamente neutralizan las intervenciones. Se intensifica la novedad por repetición del contenido, por repetición en el trabajo sobre la estructura (insistencia en lograr un acuerdo entre los padres en relación a alguna norma respecto de su hijo), o apelando al humor o la exageración.

Otro tipo de intervenciones características del enfoque estructural, son las técnicas reestructurantes.

1) Modificación en los límites.

El terapeuta interviene acercando a unos, poniendo distancia entre otros, ya sea físicamente en sesión, cambiando los lugares o buscando implicar más a alguien en relación a otro (padre en relación al hijo o hija, cuando hay demasiada cercanía con la madre), esto promueve cambios en las reglas de relación que se reorganizarán de otro modo, permitiendo más fluidez en casos de rigidez, o facilitando la claridad subsistémica en casos de demasiada permeabilidad (hijo o hija involucrados en la relación conyugal)

2) Desequilibrio.

Alianzas y coaliciones instrumentales del terapeuta, con los hijos (subsistema filial) o con uno de los hijos más aislado o débil (subsistema fraterno), o con los padres (subsistema parental) estimulándolos a aliarse como un bloque en relación a los hijos.

3) Modificación de la visión del problema.

Son intervenciones dirigidas a toda la familia, cuestionando su visión de los hechos, intenta modificar la visión del mundo de la familia, su sistema de creencias, respaldado en su experiencia o en la institución de la que forme parte.

4) Fortalecimiento de los recursos.

Es un modo de usar la connotación positiva, que tiende a mostrar a la familia que además del síntoma tienen otras potencialidades para desarrollar, busca ayudarlos a "moverse" , a explorar sus recursos y no quedar fijados a la imagen de familia ideal. (13)

El tipo de intervenciones descriptas hasta el momento, tanto de las líneas estratégicas como de la estructural, nos muestra un estilo de terapeuta directivo, que se piensa como fuerte promotor del cambio. Son terapeutas que reconocen su poder y lo usan al servicio de responder al pedido de ayuda de los consultantes .Maurizio Andolfi se formó entre otros con S. Minuchin, reconoce en él a uno de sus maestros, el lugar central del terapeuta, su actitud directiva, el control de la sesión y sus intervenciones de inducción de crisis, muestran claramente la impronta estructural en su trabajo con familias.

Andolfi , en 1984, en su texto "Terapia familiar" dice: "la terapia debe permitir al paciente identificado recuperar su capacidad de autodeterminación en un contexto familiar cambiado, donde se redescubren y activan potencialidades terapéuticas antes inexpresadas y capaces de dar un significado distinto a una perturbación, no vivida ya

como un estigma, sino como señal y momento de crecimiento de un grupo con historia" (19)

Palabras tales como: contexto, cambio, activar, perturbar, potencialidad, crecimiento, son claves en el enfoque de la escuela de Roma y hablan del modo en que el terapeuta de esta línea se piensa en relación a los pacientes y al proceso de cambio. Las intervenciones perturbadoras, de inducción de crisis, encontraron en Andolfi a uno de sus mejores exponentes. Una de sus intervenciones más conocidas fue la "provocación".Se trató de un modo de intervención muy impactante, que en muchos casos fue mal interpretada o mal aplicada. Andolfi fue muy claro al explicar teóricamente ese tipo de intervención, en la cual, si bien el enunciado estaba dirigido al paciente designado, la intervención era pensada para la familia en su conjunto. La idea era provocar la "función" que el paciente designado tenía en esa familia en ese momento, no a la persona del paciente; por eso siempre iba acompañada de otro enunciado que rescataba al paciente en su dolor y su singularidad. Generalmente se trataba de intervenciones paradojales, conocidas también como prescripciones. Muchos terapeutas inexpertos, entusiasmados con los desarrollos de la terapia familiar sistémica han usado y abusado de esas intervenciones, sin tener la solvencia teórica y la experiencia clínica necesarias, para poder intervenir de manera responsable. Esto acarreó críticas y desprestigio al marco teórico.

Partiendo del supuesto que toda forma de terapia tiene algo de directiva, Andolfi asume el lugar de poder que la familia le otorga y clasifica las intervenciones en dos grandes grupos, cada uno de los cuales incluye variantes, según cual sea el objetivo.(19)

1) Prescripciones reestructurantes

a) Contrasistémicas (desafían la homeostasis familiar)

b) De desplazamiento (desplazan el problema a otro miembro de la familia)

c) De reelaboración sistémica (reestructuran los esquemas relacionales presentes utilizando elementos existentes)

d) De utilización del síntoma (de provocación o de alianza)

2) Prescripciones paradojales

a) Prescripción del síntoma (dirigida al paciente designado)

b) Prescripciones de la reglas (implicando a la familia como un todo)

En esta primera fase de su trabajo con familias, el trabajo de Andolfi y sus colegas de Roma, mostraba la influencia de los modelos estratégico y estructural. Más adelante incorporó el pensamiento trigeneracional y con él, el trabajo en sesión incluyó la realización de rituales, cuyo objetivo era intervenir sobre los mitos (individual y familiar) y sus mutuas implicancias.(18)

Incluimos en esta reseña los aspectos más destacados, por innovadores, del grupo de Roma, como así también de los creadores de las otras escuelas; no nos es posible dar cuenta de la totalidad de sus obras, como así tampoco de sus desarrollos más actuales.

2 DIAGNÓSTICO-INDICACIÓN-ENCUADRE

El tema del diagnóstico es uno de los temas que más controversias ha generado en las diferentes líneas de terapia familiar. Durante mucho tiempo se pensó que el diagnosticar a un paciente o aceptar el diagnóstico con el que llegaba a la consulta, implicaba "rotularlo", condicionarlo, cosificarlo, limitando sus posibilidades de cambio. El término diagnóstico proviene del campo médico y apunta a identificar categorías que permitan comprender el sufrimiento y pensar en terapéuticas que aborden su resolución. Hablar de diagnóstico implica por lo tanto un criterio de salud y un criterio de

enfermedad. La terapia familiar sistémica, desde sus orígenes se caracterizó por cuestionar los criterios establecidos y vigentes en estos temas. Muchos de los debates provocados por este cambio epistemológico aun continúan, y las diferentes escuelas sistémicas no han llegado a un consenso. Desde fines de la década del 60, cuando se instala el movimiento iniciado por Bateson, hasta el presente, el desarrollo de la terapia familiar en el mundo ha dado origen a aportes muy variados y disímiles. Hoy sería más prudente hablar de "terapias sistémicas" ya que no hay un modelo hegemónico sino muchos abordajes clínicos, que si bien siguen reconociéndose como sistémicos en muchos de sus supuestos de base, difieren entre si en puntos clave.

Para transmitir conceptos actuales acerca del diagnóstico, la indicación y el trabajo con el encuadre, nos parece más adecuado hacer una breve descripción de la modelización con la cual nosotras nos manejamos hoy, ya que este es un terreno conocido y experimentado en la clínica en los últimos 27 años. No da cuenta de todas las corrientes actuales en la Argentina, pero puede ofrecer una idea de cómo se están pensando estos conceptos en una de dichas corrientes.

Cuando hablamos de diagnóstico, nos referimos a un diagnóstico relacional del sistema terapéutico, es decir que incluye al terapeuta. (cibernética de segundo orden).

Realizamos una primera etapa de intervención, a la que llamamos "Etapa diagnóstica", que consta de cuatro a cinco entrevistas. El objetivo de esta etapa de trabajo, es evaluar la disponibilidad de los miembros de la familia o pareja para un trabajo conjunto. Al finalizar dicha etapa, hacemos una Indicación que puede ser: terapia familiar, terapia de pareja, terapia individual, consulta psiquiátrica en casos graves, o algún modelo combinado de estos abordajes. Durante este período es posible la realización de entrevistas con distintos subsistemas: conyugal (pareja), parental (padres en caso de parejas separadas), fraterno(solo los hijos focalizando en las relaciones entre hermanos).

Esta metodología apunta a detectar cuales son las mejores condiciones para que cada uno de los miembros de la familia se exprese con la mayor libertad posible.

Al finalizar la serie de entrevistas deberíamos estar en condiciones de hacer una lectura relacional del padecimiento individual, es en este "recorte" que fundamentamos la indicación de un trabajo conjunto si éste es posible. (25) (30)

En general, en la entrevista de indicación hacemos un contrato con la familia o pareja de un nuevo módulo de trabajo. (El número de entrevistas acordadas depende de cada caso y siempre incluye una nueva evaluación para definir cómo continuar)

En la primera etapa de trabajo las entrevistas son casi siempre con frecuencia semanal, de una hora de duración. En las siguientes etapas y de acuerdo al caso puede ocurrir que se extienda la frecuencia a quincenal.

El trabajo sobre el cumplimiento del encuadre, como en la mayoría de los abordajes psicoterapéuticos es foco. Si alguien esperado falta o llega tarde es parte del trabajo de sesión. El terapeuta debe estar atento a estos movimientos en el encuadre, que lo incluyen. La escucha del terapeuta que se acerca a la consulta desde esta modelización está centrada en las secuencias lingüísticas en las que supone se despliegan los juegos de poder inherentes a toda relación humana. Quién habla con quién, en presencia de quién y en qué orden. Atender especialmente a la conversación, no invalida la observación de los niveles no verbales de la comunicación, son estas expresiones "silenciosas" las que muchas veces dan la posibilidad al terapeuta de intervenir con una pregunta que perturbe la "historia oficial" con que los pacientes llegan a la consulta. Nuestra modelización acompañó los cambios que se sucedieron en el campo de la terapia familiar sistémica en todas estas décadas. Conserva la impronta fundamentalmente de los grandes maestros argentinos (Sluzki, Minuchin) e italianos (Mara Selvini, Andolfi), pero cada uno de nosotros ha hecho su propia elaboración de estas influencias de acuerdo a su estilo personal, su formación previa, su historia.

Actualmente seguimos de cerca la producción teórica y la aplicación en la clínica de los supuestos construccionistas que jerarquizan las relaciones entendidas como sistemas de lenguaje y significado, no ya como interacciones o pautas de conducta repetidas. (24) (28)

El construccionismo social destaca la construcción social del conocimiento y sostiene que todo conocimiento se genera y crece "entre" las personas (27) (33). El conocimiento de sí, de su lugar en los vínculos, no escapa a este proceso. El individuo humano se construye como tal en la íntima conversación con sus otros; es en esa trama relacional continua donde desarrolla su sentido de identidad, tejido en las narraciones compartidas con los otros de sus múltiples sistemas de pertenencia: familia, familias de origen, escuela, trabajo, grupos de pares….Pensamos que el sufrimiento deviene de un "desacople" entre relatos, por el cual alguien siente y piensa que no es quien quiere ser para otro u otros significativos, esto produce sentimientos de malestar y las respuestas a este malestar desencadenan conductas que a veces conducen al síntoma. En el momento de la consulta hay alguien que se siente incierto en sus necesidades de convalidación, limitado en su autonomía, convencido tanto de su verdad como de no ser escuchado y entendido, no existe el diálogo (32) (26) (39), solo intercambios lingüísticos donde no es posible el encuentro con el otro, en los casos extremos se trata de monólogos paralelos (29). Aceptando temporalmente estos supuestos, lo que vamos a diagnosticar es la posibilidad que los miembros de la familia tienen de hablar "con" y no "de" el paciente designado . El terapeuta es aquí un agente activo de cambio en el sentido de perturbar la Historia congelada que limita, facilitando la emergencia de nuevas historias en las cuales cada uno encuentre un lugar distinto. La intervención privilegiada es ahora la pregunta que cuestiona o agrega alternativas. El objetivo del proceso terapéutico no es ya la resolución de problemas o la reorganización del sistema familiar, sino la re-

instalación del diálogo, entendido como la aceptación de distancia y diferencia. (25) (32)

En cuanto a las intervenciones pensamos que pueden ser de tres tipos:

a) de acople (tendientes a generar disponibilidad en el sistema terapéutico)

b) perturbadoras (cuestionan la historia oficial y evalúan la flexibilidad o rigidez)

c) destructivas (cuando el terapeuta se conecta más con su teoría que con sus pacientes y se adelanta con su aporte produciendo una alteración en el encuadre o una deserción)

A partir del motivo de consulta y siempre acompañando al que pide la consulta, vamos co- construyendo el sistema terapéutico, quedaron atrás los tiempos en que el terapeuta decidía unilateralmente quién venía o no a las entrevistas, se trata sin embargo de una co-construcción diferenciada que no elude la responsabilidad del terapeuta que es consciente del poder que le delegan los pacientes en el momento de la consulta. La unidad mínima de análisis es siempre una secuencia de tres enunciados: enunciado del paciente, respuesta o propuesta del terapeuta, respuesta del paciente. Este cambio en el tipo de intervenciones y en el manejo de la dinámica de las sesiones, muestra el pasaje de un interés en las conductas a un énfasis en las conversaciones que revela una profunda transformación en el modo de entender la construcción de la subjetividad, un cambio en el concepto de psicoterapia y como consecuencia un terapeuta que piensa en otros términos su lugar en el proceso (25)

Caso Clínico

La familia

Alfredo de 51 años

Silvia de 48 años (tercera esposa de Alfredo)

Francisco de 22, hijo de Silvia de su primer matrimonio con Mario

Marcela de 50 años (segunda esposa de Alfredo)

Sebastián de 19 años

Mariano de 14 años

Marina (primera esposa de Alfredo, fallecida hace muchos años)

Verónica de 30 años, hija de Alfredo y Marina, residente en Bélgica.

Motivo de consulta

Pidió la consulta Silvia, tercera esposa de Alfredo, por sugerencia del neurólogo que atiende a Sebastián.

Sebastián, hijo de Alfredo y Marcela, tuvo un grave accidente esquiando en Europa; sufrió una importante hemorragia cerebral y debido a serias fracturas fue operado y necesitaba rehabilitación por problemas motrices en su pierna y brazo izquierdos. Las dificultades para el cumplimiento del tratamiento de Sebastián, motivaron en el neurólogo la sugerencia de una consulta familiar.

Sebastián no podía trasladarse solo y en varias oportunidades no concurrió a las sesiones de terapia física o control neurológico, porque no había nadie que lo acompañe.

Datos de la historia-Contexto familiar

Alfredo tuvo un primer matrimonio con Marina, del cual tuvieron una hija, Verónica de 30 años. Poco después del divorcio, Marina y Verónica se instalaron en Bélgica, país de origen de la familia de Marina. Años después Marina falleció y Verónica se radicó en Bélgica, nunca regresó a Argentina, tenía muy poca relación con su padre; el de Alfredo y Marina fue un divorcio destructivo y Verónica quedó ligada fuertemente a su madre perdiendo la relación con su padre. Durante años se hablaban por teléfono solo para las fiestas o los cumpleaños, hasta que lentamente disminuyeron los llamados. En los

últimos tres años previos al accidente de Sebastián no habían mantenido ninguna comunicación.

Sebastián y Mariano son hijos de Alfredo y su segunda esposa, Marcela. También este fue un divorcio destructivo, la relación de Alfredo con Silvia comenzó antes de su divorcio de Marcela, los hijos tomaron partido por su madre, mantenían una conflictiva relación con su padre y Sebastián durante mucho tiempo fue la "bisagra" que conectaba a ambas partes de la familia. Era el encargado de pedir al padre el dinero que éste le pasaba a Marcela y de transmitir mensajes entre sus padres que casi no se dirigían la palabra.

En el momento de la consulta, Alfredo y Silvia, convivían con Francisco, hijo del primer matrimonio de Silvia.

Sebastián convivía con su madre y su hermano Mariano.

Durante un viaje de Alfredo y Silvia al exterior, Sebastián se fue a Bélgica a visitar a su hermana Verónica sin que su padre estuviese informado. Es en ese viaje que ocurre el accidente y tanto Alfredo como Silvia responsabilizan a Verónica.

El accidente cambió drásticamente las conductas de todos los miembros de la familia y sus relaciones se modificaron, cambiaron las alianzas y emergieron viejos conflictos no resueltos entre algunos de sus miembros.

Primera entrevista

A la primera entrevista concurren: Alfredo, Silvia, Marcela, Sebastián, Mariano y Francisco.

En el consultorio se sientan Alfredo entre Silvia y Marcela, dejando una silla vacía se ubica Francisco y un poco más distante Sebastián, al lado de éste último se sienta Mariano que llega tarde. La silla vacía separa a los adultos de los jóvenes y Alfredo queda sentado entre su ex mujer y su mujer actual.

El terapeuta inicia la sesión explicitando que habló con Silvia, ya que fue ella quién pidió la consulta y pregunta quién quiere comenzar a contarle cómo ve las cosas cada uno, qué piensan de la sugerencia que hizo el neurólogo en relación a lo ocurrido a Sebastián.

Toma la palabra Alfredo. Es un hombre corpulento, de voz potente que "llena" el espacio con su relato, plagado de expresiones acusatorias hacia Marcela, Verónica y Mariano. Cuenta detalladamente el episodio del accidente, sus esfuerzos por conseguir la mejor atención para su hijo, su rabia por haber sido excluido de la decisión del viaje de Sebastián a Bélgica, destaca en todo momento su preocupación por la evolución de Sebastián y deja clara su crítica a la actitud tan pasiva de Marcela y Mariano en relación a colaborar con las necesidades de Sebastián para su recuperación.

A continuación Marcela pide ser la próxima en hablar ya que se tiene que retirar temprano, "a mi me avisaron a último momento" dice y comienza a dar su opinión que es totalmente distinta a la de Alfredo: "el accidente fue un accidente, pudo pasarle a cualquiera, es ridículo inculpar a Verónica ...", "Sebastián está bien, está recibiendo todo lo que necesita, yo si no lo acompaño más es porque tengo que trabajar , porque a mi nadie me mantiene, trabajo todo el día y no puedo pagar más ayuda de la que tengo dos veces por semana…" "fue grave lo que le pasó pero ya está, ahora está bien, no tiene sentido insistir en lo que pudo ser, hay que mirar para adelante.." "si Sebastián no le contó al padre que se iba es porque los chicos le tienen miedo" "yo no hubiera pedido esta consulta pero si usted cree que le servirá cuente conmigo".

Cuando Silvia comienza a hablar Marcela mira constantemente el reloj, niega con la cabeza algunas de las expresiones de Silvia que coincide en todo con lo expresado por Alfredo y el juego relacional va desplegándose, mostrando el tono típico de los circuitos de la violencia: enunciados con fuerza de verdad, certezas expresadas con gestos y palabras que descalifican al otro, acusaciones, reproches.

Marcela se va pero que queda su representante: Mariano. Cuando le toca su turno adhiere en un todo a lo expresado por su madre, enfrentando la versión de su padre que apoya Silvia.

Francisco recorta rápidamente su lugar, él no entiende demasiado el porqué de su presencia en la consulta, asistió porque su madre se lo pidió, le duele que Sebastián haya pasado por una experiencia tan difícil, pero piensa que no puede aportar demasiado y que si hay problemas, no tienen que ver con él.

Sebastián habla desde su dolor por no sentirse acompañado por su madre y su hermano, cree que ellos minimizan lo ocurrido y lo complicado de su situación, realza la conducta del padre y lo mucho que esto los acercó a él con Alfredo y a él con Silvia. Transmite su sensación de cambio irreversible en su actitud de vida a partir de esto que vivió como situación límite y la necesidad de un espacio para pensar en cómo vivir en adelante.

Cada uno tuvo su espacio para hablar, este es uno de los objetivos de una primera entrevista, que cada uno pueda expresarse frente al otro, dar su opinión, mostrar sus desacuerdos, existir en su palabra, escuchar y ser escuchado en su diferencia.

Las preguntas del terapeuta y el clima que va creando en su atención alternada a todos, favorece esta posibilidad. Las respuestas de los pacientes a esta propuesta, permiten al terapeuta desde la primera entrevista ir evaluando la disponibilidad para un trabajo conjunto. La idea es a partir del motivo de consulta, armar un circuito relacional que los incluya, dándole sentido al sufrimiento individual.

En este caso Alfredo, Silvia y Sebastián piden ayuda, vinculan su sufrimiento a otro u otros significativos y aceptan trabajar de manera conjunta. Marcela, Mariano y Francisco no piden nada, no creen necesitar ayuda y ponen condiciones para un trabajo conjunto.

Las palabras clave de esta entrevista fueron: ACCIDENTE-EXCLUSIÓN-MIEDO-VIOLENCIA-RABIA-DOLOR.

Estas palabras serán exploradas en las siguientes entrevistas de la etapa diagnóstica:

Sebastián solo

Alfredo con Silvia

Sebastián con su mamá y su hermano

Terminada la etapa diagnóstica la indicación fue de terapia de pareja para Alfredo y Silvia; allí fue apareciendo el miedo, la rabia el dolor y la violencia. Ambos estaban dispuestos para un trabajo conjunto.

A Sebastián se le indicó terapia individual con la posibilidad de algunas entrevistas conjuntas con alguno de los padres.

Frente al pedido de una consulta familiar, nos parece importante tener en cuenta quién pide la consulta, suponemos que es la persona que en ese momento está más necesitada, más sola o más incierta en su lugar.

Silvia que ya tenía dificultades en su relación con Alfredo se alegró del acercamiento de éste a Sebastián y lo estimuló, pero también empezó a vivir sentimientos de exclusión en la fuerte alianza de sangre de padre e hijo.

Marcela que siempre consideró a Sebastián un aliado suyo en la "lucha" con Alfredo, se sintió traicionada por Sebastián y reacciona poniendo distancia; Sebastián que no pudo vivir libremente la relación con su padre por haberse sobre involucrado en el dolor y el enojo de su madre, ahora resentido con ella por no sentirse suficientemente acompañado, "elige" acercarse a Alfredo que le ofrece toda su disponibilidad para colaborar con su recuperación y sostenerlo en un momento tan difícil de su vida. Para Alfredo es la oportunidad de "mostrarle" a Marcela que no es mal padre y que sus hijos no le tienen miedo. La sorpresa para él fueron los reclamos de Silvia.

La indicación colaboró desde el encuadre, pareja para Silvia y Alfredo e individual para Sebastián, a desenredar la trama relacional en la que estaban inmersos: resabios de un

divorcio destructivo[7]; hijo triangulado en el conflicto de sus padres; reproducción de modelos de resolución de los adultos en la relación entre hijos y padres (conflicto entre Alfredo y Marcela ahora en la relación de Marcela con Sebastián); temas pendientes en la relación de Silvia con Alfredo que nunca abordaron por "perderse" en el cúmulo de problemas con los hijos.

7 Ver M.R. Glasserman "Hijos del divorcio del ciclo vital y del divorcio destructivo" en *Más allá de pactos y traiciones.*

Bibliografía

(1) Bateson, Birdwhistell, Jackson y otros. La nueva comunicación. Barcelona 1984. Editorial Kaidos

(2) P. Watzlavick, D. Jackson, J. Beavin. Teoría de la comunicación humana. Bs. As. 1971. Editorial Tiempo Contemporáneo.

(3) Bertalanffy. Teoría General de los sistemas. México 1976. F.C.E

(4) Prygogine, I. y Stengers, I.: La Nueva Alianza (metamorfosis de la ciencia). Alianza Universidad, Madrid, 2002

(5) Andolfi Murizio, Angelo Claudio., Menghi Paolo y otros. Detrás de la máscara familiar. La familia rígida. Un modelo de psicoterapia relacional. Buenos Aires 1985, Amorrortu Editores

(6) Sluzki, Carlos. "cibernética y terapia familiar. Un mapa minimo". En revista Sistemas familiares. Año 3 Nº 2. 1987.

(7) Von Foerster Heinz. Semillas de la cibernética. 1999. Gedisa Editorial

(8) Maturana H.. Emociones y lenguaje en educación y política.. Santiago de Chile. 1997. Dolmen Ediciones.

(9) Maturana H. EL sentido de lo humano. Dolmen Ediciones

(10) Bertrando Paolo y Toffanetti Darío. Historia de la terapia familiar, los personajes y las ideas. Barcelona, España 2004. Piadós.

(11) Boscolo, Luigi; Bertrando, Paolo. Terapia sistémica individual. Buenos Aires 2000. Amorrortu Editores

7

(12) Minuchin, Salvador. Familias y terapia familiar. Buenos Aires 1982. Ed. Gedisa

(13) Minuchin Salvador y Fishman H.Ch., Técnicas de terapia familiar, Paidós, 1984, Barcelona, España

(14) Minuchin, Salvador y Nichols, Michael. La recuperación de la familia. Relatos de esperanza y recuperación. 1994. Paidós Ibérica.

(15) Madanes Cloé. Terapia familiar estratégica, Buenos Aires – 1989 - Amorrortu Editores

(16) Haley Jay.: Terapia para resolver problemas, nuevas estrategias para una terapia familiar eficaz. Buenos Aires 1984. Amorrortu Ed.,

(17) Haley Jay. Terapia no convencional. Buenos Aires 2003. Amorrortu Ed.

(18) Andolfi Maurizio y Angelo Claudio. Tiempo y mito en la psicoterapia familiar. 1989 Paidós

(19) Andolfi Mauricio: Terapia familiar. Buenos Aires 1984. Piados.

(20) Selvini, Matteo (comp.). Crónica de una investigación. Barcelona 1990. Paidos.

(21) Selvini Palazzoli, Mara; Cirillo, Stefano; Selvini, Mateo; Sorrentino, Anna María. Los juegos psicóticos en la familia. Buenos Aires 1990. Ed. Paidós

(22) Morin Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona 1995. Ed. Gedisa.

(23) Schnitman, Dora (comp.) Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Buenos Aires 1994. Ed. Paidós

(24) Anderson, Harlene: Conversación, lenguaje y posibilidades. Un enfoque posmoderno de la terapia. Buenos Aires 1999. Amorrortu Editores

(25) Droeven, J.(compiladora), Más allá de pactos y traiciones. Construyendo el diálogo terapéutico. Buenos Aires, Ed. Grama, 2004

(26) Gergen K.J. "La comunicación terapéutica como relación". Revista Sistemas Familiares Año 13 Nº 3 1997

(27) Gergen K.J. y Warhuus L. "La terapia como construcción social. Dimensiones, deliberaciones y divergencias". Revista Sistemas Familiares Año 17 Nº 1 2001

(28) Hoffman L. De la sabiduría sistémica a la responsabilidad relacional: una perspectiva comunal. Revista Sistemas Familiares Año 17 Nº 2 2001

(29) Loketek, A. “Microviolencia familiares. De pactos, transgresiones, traiciones y castigos” en Más allá de pactos y traiciones. Construyendo el diálogo terapéutico (op. cit.) pág. 238.

(30) “Diagnóstico e indicación en terapia familiar” en Más allá de pactos y traiciones. Construyendo el diálogo terapéutico. (op.cit.) pág. 148.

(31) Boscolo, Luigi. Los tiempos del tiempo. 1996. Piadós Ibérica.

(32) Gadamer Hans Georg. La incapacidad para el diálogo en Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica.. Tomo II. Sígueme, Salamanca, 1988.

(33) Gergen K.J. “El movimiento del construccionismo social en la psicología moderna”. Revista Sistemas Familiares Año 9 Nº 2 1993

(34) Glasserman, María Rosa y otros. La Práctica de la terapia familiar. Un encuentro clínico Buenos Aires 2002. Editorial Libros del Zorzal

(35) Dio Bleichmar, Emilce. Manual de Psicoterapia de la relación padres e hijos. Paidós

(36) Sluzki, Carlos. Atractores extraños y la transformación de las narrativas. Revista Sistemas Familiares Año 13 Nº 2 1989

(37) Morin Edgar. El Método I. La naturaleza de la naturaleza. Madrid 1981. Cátedra.

(38) Morin Edgar. El Método III. El conocimiento del conocimiento. Madrid 1988. Cátedra.

(39) White, Michael y Epston, David. Medios narrativos para fines terapéuticos. 1993 Paidós.

(40) Loketek, Adolfo. “Breve historia de la terapia familiar”. Ficha CEFYP Nº 341. 1999

(41) Elkaïm Mony. Si me amas, no me ames . Psicoterapia con enfoque sistémico. Bs. As. 1989. Ed. Gedisa

(42) Gergen Kenneth. Construir la realidad. El futuro de la psicoterapia. Barcelona 2006. Paidós.

(43) Maturana, H. y Varela, F. (1984). El árbol del conocimiento. Madrid 1996,Editorial Debate.